HOSPITALES DE COSTA RICA

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION COSTARRICENSE DE HOSPITALES

Número 4 Ene-Mar 1980



Pag. 3
HECHOS HISTORICOS DEL HOSPITAL "WILLIAM ALLEN" DE TURRIALBA

Pag. 11
UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO SOCIAL HOSPITALARIO

Pag. 25
INFORMACIONES SOBRE ACTIVIDADES DOCENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Pag. 34
COMISION PARA PREPARAR EL RETIRO Y JUBILACION EN EL SEGURO SOCIAL

HOSPITALES DE COSTA RICA
ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION COSTARRICENSE DE HOSPITALES
TEL. 21-49-19. APARTADO 745
SAN JOSE, COSTA RICA

DIRECTOR: Roberto Loría Villarreal
COMITE EDITOR: Sr. José M. Barrionuevo M.
Sr. Arturo Arias Jiménez
Dr. Fernando Trejos Escalante
Dr. Edgar Cabezas Solera
Dr. Manrique Soto Pacheco
Dr. Lenín Sáenz Jiménez
Dr. Edgar Mohs Villalta
ENCARGADO DE PUBLICIDAD: Sr. Carlos Artavia A.

PRESIDENTES HONORARIOS:

Monseñor Dr. Carlos H. Rodríguez Quirós
Dr. Antonio Peña Chavarría
Dr. Raúl Blanco Cervantes
Dr. Carlos Sáenz Herrera
Dr. Fernando Trejos Escalante
Ing. Charles S. Pineo
Sr. Gordon A. Friesen
Dr. Antonio Ríos Vargas
Dr. Martín Vázquez Vigo

DIRECTIVA:

Presidente efectivo:
Sr. Roberto Loría Villarreal

Presidente electo:
Dr. Minor Vargas Baldares

Ex-presidente:
Dr. Otto Valverde Acosta

Secretario:
Sr. José Ma. Barrionuevo M.

Tesorero:
Sr. Arturo Arias Jiménez

Fiscal:
Sr. Antonio Alegría González

Primer Vocal:
Srita. María de los A. Porras Z.

Segundo Vocal:
Sr. Miguel Carmona Jiménez

Tercer Vocal:
Sr. Rafael A. Murillo Sandoval

Primer Suplente:
Sr. Mario Loaiza Jiménez

Segundo Suplente:
Dr. William Guevara Barrantes

Tercer Suplente:
Sra. Claudia Quesada Navarro

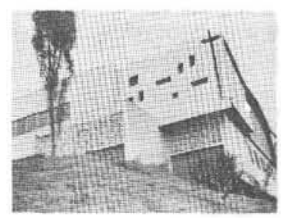
en este número

Número 4 Volumen VI

Enero - Marzo 1980

Pág.

Directorio de la Asociación Costarricense de Hospitales (Vol VI, No. 4 - enero - marzo 1980. 1
Editorial 2
Hechos Históricos del Hospital "William Allen" de Turrialba 3
Medicina de la Colonia 7
Una Experiencia de Trabajo Social Hospitalario 11
Reflexiones sobre el Estado Actual y el Futuro de la Salud Infantil en Costa Rica 16
Informaciones sobre el IV Curso Nacional de Administración de Hospitales 24
Informaciones sobre actividades docentes a nivel nacional e internacional 25
Humanismo y Medicina 26
Participación del Hospital como generador de desarrollo y bienestar humano en su área de atracción 27
Comisión para preparar el retiro y jubilación en el Seguro Social 34



NUESTRA PORTADA

Vista del Hospital de Turrialba.

REPRODUCCION DE ARTICULOS ORIGINALES

Se permite la reproducción de artículos originales siempre que no se resuman, que se mencione el nombre del autor y de esta revista, y que se remita a dicho autor, a través de la Administración de Hospitales de Costa Rica, Apartado 745.

Esta publicación llega a los siguiente países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Inglaterra, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Perú, Cuba, España y Portugal.

Las opiniones emitidas, en los trabajos que aparecen en esta Revista, expresan exclusivamente el criterio de sus autores.

EDITORIAL

Hemos estado meditando un poco sobre el estado actual de la medicina asistencial y aunque tenemos datos que dicen que en este sector las cosas van hacia una reorganización vemos un futuro no muy halagador por lo menos en lo que a finanzas se refiere.

Funcionarios de alto nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social han informado públicamente la derrota económica que está obteniendo esa institución con el programa exigido de integración hospitalaria y con la universalización de los servicios médicos.

El Estado no le quiere hacer frente a la deuda BID-CAJA sino que ésta debe poner los intereses y la amortización. El Gobierno le exige a la Caja el 10 por ciento de subejecución de su presupuesto; el Gobierno le exige a la Caja la compra de bonos por cerca de los 161 millones, no obstante que ya tiene 2000 mil millones de ellos a un promedio del 4 por ciento de interés anual. El Estado le debe 1000 millones por cuotas patronales. El Estado no le paga los servicios médicos que la Caja le presta a los asegurados por el Estado cuyo monto alcanza en 1979 a la cifra superior a 400 millones. En fin podemos seguir inflando el déficit de ingresos que la Caja sufre a consecuencia muy especialmente de la falta de cumplimiento del Estado con sus obligaciones con la Caja.

Sin embargo, no debe perderse de vista el proceso inflacionario que sufre el país, el alto costo de los materiales y productos básicos de consumo intra-hospitalario y, en especial, los aumentos de sueldos cuyo presupuesto abarca más del 65 por ciento del total de cada hospital. Y qué decir, del incremento de servicios médicos en que el problema se agudiza. Sólo veamos estos datos. En 1977 el número de consultas externas que se atendieron en todo el país, fue de 6.052.353, el número de exámenes de laboratorio 6.531.742; los medicamentos despachados fueron 15.237.310, y por todo lo anterior, se llegará a subir la cuota patronal y del trabajador para hacerle frente al gran problema? , o se estará buscando un cambio de sistema que logre evitar lo primero.

Estará el gobierno central estudiando todos los caminos que le planteó a los costarricenses en el programa oficial de la campaña política, o simplemente se está siguiendo muy cómodamente lo que el gobierno anterior había dejado?

Por lo que hemos leído estamos dudosos que se estén buscando los mejores mecanismos para resolver estos problemas: El financiero, servicios médicos más oportunos y humanitarios, el desgano o insatisfacción empleado-paciente, que coadyuva a subir el mal clímax a que está llegando el sistema.

Será hora de una revisión general del Sector Salud, de la Seguridad Social como lo están recomendando especialistas?

El Ministerio de Salud y la C.C.S.S. deben llegar al acuerdo de no regionalizar ambos. Por qué dos grupos de regiones de salud, por qué dos jefes o directores de región o de zona? Por qué dos equipos multidisciplinarios dirigiendo zonas geográficas de salud casi iguales? No podrá ser una zona o región de salud con un sólo director para medicina preventiva y curativa? Estas y otras preguntas se hacen los especialistas en salud, pero sólo el gobierno tiene las respuestas.

¿Qué pasó con el Servicio Nacional de Salud?

¿Qué pasó con el programa Seguridad Social y Salud Pública, declarado en la campaña política y que fue aprobado por los costarricenses?

HECHOS HISTORICOS DEL HOSPITAL "WILLIAM ALLEN" DE TURRIALBA

Por Carlos Solano Salazar
Trabajo presentado
III Congreso Nal. de Ad. de Hospitales
1974

El Hospital de Turrialba fue construido en el año de 1927, en terreno donado por don Florentino Castro Soto, situado en la parte oeste de la ciudad en una loma, por donde también pasa la carretera nacional Turrialba-San José de hoy. Su planta física fue posible gracias a la donación de ₡ 40.000.00 de las familias Allen Taylor, (familia de John Allen Taylor y familia de William Allen Taylor), y con el aporte de muchos turrialbeños que en esa época decidieron levantar este centro médico para hacerle frente a las enfermedades tropicales que estaban diezmando a la población en toda la región Atlántica.

Un año después, la institución hospitalaria contaba con el siguiente inventario:

VALOR EN INVERSIONES

Valor del edificio	₡ 90.737.05
Valor de la manzana	27.000.00
Invertido en Cirugía Menor	10.370.00
Invertido en Mobiliario	11.847.00
Utencilios cocina y comedores	1.987.50
Invertido en Ropería	3.609.40
Existencia en Botica	4.818.50
Un caballo para médicos	210.00
	₡ 150.579.45

La primera Junta de Caridad de este Hospital, estuvo formada por las siguientes personas:

PRESIDENTE	DON JOHN E. ALLEN
VICE-PRESIDENTE	Don Enrique Westerman
SECRETARIO	Don José Joaquín García
VOCALES	Don Joaquín Jiménez P.
	Don Ricardo Quesada
	Don Federico Pérez R.
	Don M.C.B. Goode
FISCAL GENERAL Y CONTABILIDAD	Don Tito Livio Solera
FISCALES AUXILIARES	Don Jesús Sáenz V.
	Don Joaquín Salazar
TESORERIA	Rivera y Cía Sección Bancaria
DIRECTOR	Dr. Vicente Santivañez Médico Director
MEDICOS AUXILIARES	Dr. Carlos Umaña C.
	Dr. Alfonso Portocarrero
DIRECTORA Y ECONOMA	Doña Paulina de Ezeguerra (Doña Paula de Anchetta)

El personal técnico del Hospital devengaba los siguientes sueldos:

Dr. Vicente Santivañez, Jefe y Encargado de la Cirugía, interno en el Hospital y a su cuidado un pabellón, atendiendo todos los casos que se presentaban en el día o en la noche: *MIL COLONES MENSUALES.*

Dr. Carlos Umaña. Con obligación de ayudar en la cirugía, en el día o en la noche, a su cuidado otro pabellón, una parte del consultorio y *visitas periódicas a algunas fincas: OCHOCIENTOS COLONES MENSUALES.*

Dr. Alfonso Portocarrero. Encargado de otra sección del consultorio, con obligación de ayudar la cirugía en el día o en la noche y con *visitas periódicas o algunas fincas: CUATROCIENTOS COLONES MENSUALES.*

1.1 – INFORME DE LABORES.

En su primer informe anual de labores, la Junta de Caridad, expresa algunos conceptos muy importantes:

PRIMERA JUNTA DE CARIDAD DE TURRIALBA



Don Tito Livio Solera, Fiscal y Contabilidad; don Ricardo Quesada, Vocal; don John E. Allen, Presidente; don Enrique Westerman, Vice-Presidente; don Federico Pérez, Vocal; don Joaquín Jiménez P., Vocal; don Jesús Sáenz, Fiscal Auxiliar.

"La población de Turrialba y otros pueblos vecinos, en un setenta por ciento, se compone de elemento trabajador en las fincas, el cual no puede pagar asistencia médica, como puede pagar el habitante acomodado de las ciudades centrales. Por eso la creación del IMPUESTO DE BENEFICENCIA, DISTRIBUIDO EN UN TRES POR CIENTO PARA EL PEON y UN DOS POR CIENTO PARA EL FINQUERO, requiere tratarlo extensivamente para poder llegar a comprender las razones citadas en este informe."

Otro párrafo:

"El gobierno y sostenimiento del Hospital ha sido el de una casa pobre; muchas veces se ha demorado la cancelación de facturas por provisiones, por medicinas o por otros conceptos. En más de una ocasión algunos establecimientos han rechazado órdenes enviadas por el encargado de aprovisionamiento, pero no por esto las puertas del Hospital se iban a cerrar . . . "

Otro párrafo:

" . . . Comprendemos que todas estas dificultades desaparecerán cuando la vida de la Institución esté asegurada por la organización económica definitiva que actualmente nos desvela. Un poco de buena voluntad del Poder Ejecutivo y lograremos éxito y con el éxito estaremos recompensados suficientemente . . . "

Toda esta información la hemos recogido del folleto publicado sobre la labor realizada en el Hospital "William Allen" de Turrialba, durante el año de 1928 (Imprenta Alsina-Sauter Arias y Co., San José, C.R.).

Se puede apreciar el edificio de madera original, con su pabellón de Medicina para mujeres, con su pabellón de Medicina para hombres, su sala de Cirugía, el Laboratorio Bacteriológico, un amplio hall en el centro, corredores internos, comedores, cocina y bodega y desde luego, desde el Hospital una vista panorámica de la ciudad de Turrialba, con sus palmeras, sus calles angostas de tierra, sus pocas casas de madera, donde se destacan solamente dos edificios grandes, su Iglesia Católica y el edificio de Felipe Royo.

Concluye esta primera parte histórica del informe, con el primer reporte anual de caja, sobre ingresos y gastos del Hospital, como sigue:

AÑO DE 1928

SUMA TOTAL DE LOS INGRESOS ₡100.841.05
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS . ₡101.710.00
SOBREGIRO DE CAJA AL 31 DIC ₡1928.868,95

Se puede observar cómo esta naciente entidad hospitalaria, desde el principio, tenía serias dificultades económicas. El Poder Ejecutivo sólamente otorgaba una subvención mensual de ₡ 2.000.00. La Municipalidad solo aportaba ₡405.00 por mes. El resto era logrado a las contribuciones de los finqueros, (que no eran regulares) y las limosnas de otras gentes y pacientes.

Es curioso que hoy en día —46 años después— aún los Hospitales a cargo de las Juntas de Protección Social, todavía viven las mismas penalidades económicas, si se quiere más graves, por el crecimiento de la población indigente y la falta de una política financiera del Gobierno Central más acorde con las necesidades de la población enferma.

El Hospital "William Allen" de Turrialba, siguió trabajando en estas condiciones, gracias a la tesonera voluntad de sus creadores y a la necesidad de una población de reconocida pobreza, dado que en su mayoría sus mejores clientes eran los integrantes de familias con salarios muy bajos, impuestos por las grandes empresas bananeras establecidas en esta región y de fincas cafetaleras cuyos propietarios disfrutan sus ganancias en la capital y en viajes al exterior. (United Fruit Co., Compañía Bananera de Costa Rica, Hacienda Atirro, Hacienda Aquiares, Hacienda Florencia, etc.).

Pasan los años y estamos ante uno de los libros de actas de la Junta de Caridad o Junta de Protección Social, sobre administración del Hospital en los años 1941 a 1949.

Integrantes de la Junta Directiva, otras personas, que nuestro cantón recuerda con cariño:

PRIMER CUERPO TECNICO Y DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL



Don José Fuentes, Enfermero; Srita. Teresa Villalobos, Enfermera; doña Paulita Ezeguerra de Anchetta, Directora; Dr. Carlos Umaña, Médico Auxiliar; Dr. Vicente Santivañez, Médico Director; don Manuel Guzmán, Farmacéutico; Srita. Rosaura Calvo, enfermera; Srita. Pilar Solano, ayudante botiquín, de pie, don Ismael Reaño Vera, Ecónomo y encargado Registro consultorios y hospitalarios.

Don Florentino Suárez Fernández, don Rolando Ugalde Hidalgo, don Manuel Bonilla Baldares, don Miguel Ramírez Serrano, don Cástulo Jiménez Aguilar, don Manuel Rojas Rojas.

Podemos reproducir algunos acuerdos, —los más importantes—, que reflejan el desastre económico, insostenible por la Junta, —la entrega del Hospital a la Caja—, el abandono de funciones, la deuda por servicios que nadie pagó y el regreso de la Junta.

"Art. II.—Sesión de 22 de octubre 1942. Después de las diligencias realizadas por esta Junta, ante el señor Presidente de la República Dr. don Rafael Angel Calderón Guardia; se acuerda: pasar a conocimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, un informe del Pasivo y Activo de nuestro Hospital "WILLIAM ALLEN" y por tanto de la Junta de Protección Social de esta localidad".

"Art. III.—Sesión de 17 diciembre 1942". "Acuérdase: Dirigirse al señor Presidente de la República, Dr. don Rafael Angel Calderón Guardia, exponiendo la situación económica cada vez más angustiosa de nuestro organismo y recordando, su bien intencionado y sabio criterio, en relación a la Caja Costarricense de Seguro Social, y nuestro Hospital".

"Art. II.—Sesión 7 febrero 1943: Leído en contrato, celebrado por el Sr. Ing. don Jaime Granados Chacón debidamente autorizado y en calidad de Presidente de la Junta de Protección Social de Turrialba y el señor Gerente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Lic. don Julio Acosta García, en condición igualmente autorizada; por unanimidad, los miembros presentes de la Junta de Protección Social de Turrialba, acordamos:

"Aceptar y aprobar, en todas sus partes, lo actuado y convenido, en el siguiente contrato: La Junta de Protección Social de Turrialba, representada por su Presidente Ing. don Jaime Granados Chacón, debidamente autorizado al efecto y la "Caja Costarricense de Seguro Social, representada por su Gerente don Julio Acosta García, con instrucciones bastantes de su mandante, han celebrado el siguiente contrato:

"1o. La primera cede y traspasa en plena propiedad, a la segunda, que acepta, el Hospital "WILLIAM ALLEN", situado en Turrialba, formando la finca inscrita en el Registro de la Propiedad, Partido de Cartago, tomo 1142, folio 222, número 40134 asiento uno, que es terreno de una manzana con todo el edificio allí ubicado. Cede y traspasa también en plena propiedad, como parte del Hospital, el equipo, mobiliario y menaje de este último, con todos los accesorios que lo completan, instrumentos de cirugía, batería de cocina, laboratorio, botica (existencias), todo según inventario practicado el día 23 de diciembre de 1941 y otro que se llevará a efecto oportunamente.

2o.—La "Caja Costarricense de Seguro Social" toma a su cargo la cancelación de todo el pasivo que adeuda dicho Hospital según cuentas cortadas el día 31 de diciembre último en cantidad de ₡ 46,698. 39 (cuarenta y seis mil seiscientos noventa y ocho colones con treinta y nueve céntimos). Además la "Caja" arreglará extrajudicialmente con los herederos del señor William Allen el pago de la suma a que fue condenada por sentencia firme. La Junta de Protección Social de Turrialba en el reclamo incoado por ellos ante el Juzgado Civil de Hacienda, todo sin gar a reembolso ni otra indemnización.

3o.—La "Caja" tomará posesión del edificio y demás dependencias del Hospital y se hará cargo de su operación y mantenimiento, cuando entre en vigencia la ley que autorice el traspaso en propiedad a la "Caja", pero es entendido que los fondos que haya tenido que suplir el Presidente de la Junta, señor Granados, para atender los gastos indispensables del Hospital a partir del primero de febrero próximo entrante hasta la fecha en que la Caja tome posesión del mismo le serán reembolsados por esta si en definitiva se hace cargo de dicho Hospital.

4o.—La Junta de Protección Social de Turrialba, seguirá atendiendo por su cuenta los enfermos pobres de dicho cantón que por cualquier motivo no ingresen o figuren como miembros del Seguro Social; para este efecto ambas partes, de mutuo acuerdo fijarán la tarifa por estancia diaria de cada enfermo y el costo mensual será pagado preferentemente de las rentas que tiene derecho a percibir la Junta de Protección Social. Para evitar demoras en dicho pago y expeditar el procedimiento, la Caja de Seguro Social, por medio de su tesorería, recibirá directa e íntegramente, el importe de esas rentas, hará la liquidación mensual de los que se le adeuda por los servicios expresados y devolverá el saldo, si lo hubiere, a la mayor brevedad haciéndolo ingresar en la Tesorería de dicha Junta.

5o.—La Junta de Protección Social de Turrialba cede y traspasa todos sus derechos y acciones a la Caja de Seguro Social para el cobro de todos los impuestos de hospitalización que adeudaren los finqueros o hacendados del Cantón de Turrialba que no hubieren afectado oportunamente el pago del impuesto a que se refiere la ley 23 de abril de 1920; pero es entendido expresamente que el total de lo que se recaude por ese concepto deberá ser invertido íntegramente en las mejoras que demanda el edificio, ampliación de salones y establecimiento de los nuevos servicios, como salón de maternidad, salón de aislamiento para enfermedades infecciosas, rayos X, etc.

Ambas partes solicitarán al Poder Ejecutivo que se sirva pedir al Congreso la aclaración y aditamientos necesarios de la citada ley que permitan el examen de libros, contrastes de planillas o cálculos

periciales para fijar las sumas líquidas y exigibles que adeuden dichos hacendados y la necesaria autorización para entrar en arreglos con ellos en cuanto a la forma de pago, reducción del total en casos muy justificados, prescindiendo del cobro judicial si fuere del caso.

6o.—La "Caja" extenderá lo más pronto los servicios del Seguro Social a todo el Cantón de Turrialba y desde esa fecha dejará de surtir sus efectos el Acuerdo de 23 de abril de 1920, ratificado por Ley No. 3 de 9 de diciembre de ese mismo año y reglamentado por Acuerdo No. 35 de 14 de mayo de 1929, cuya derogativa se pedirá también el soberano Congreso.

7o.—Si las circunstancias lo aconsejaren, la Directiva del Seguro Social y la Junta de Protección Social podrán convenir, por voto unánime de sus miembros, que el Hospital pase a ser de nuevo propiedad de dicha Junta.

8o.—La validez de este convenio quedará sujeta a la autorización que debe conceder el Congreso para el traspaso en propiedad de la finca mencionada, así como de los bienes muebles del Hospital y de los derechos y acciones emanadas del Acuerdo de 23 de abril de 1920, de que se ha hecho referencia, siempre que esa autorización se obtenga en los términos consignados en el proyecto de ley respectivo o en forma que considere aceptable la "Caja".

"En fé de lo cual firmamos en la ciudad de San José, a las catorce horas del dos de febrero de mil novecientos cuarenta y tres".—Julio Acosta García, Gerente de la "Caja Costarricense de Seguro Social '.— Jaime Granados Chacón, Presidente de la Junta de Protección Social de Turrialba.

Posteriormente, el 11 de abril de 1943, el Congreso Constitucional de Costa Rica dictó la Ley No. 41, que otorgó carácter legal al contrato de traspaso del Hospital "WILIAM ALLEN" a la Caja Costarricense de Seguro Social. Este Decreto fue refrendado por el Presidente de la República Dr. Rafael Angel Calderón Guardia.

Al dictarse esta ley eran miembros de la Junta de Protección Social de Turrialba, don Jaime Granados Chacón, Presidente; don Edwin Murillo Cartín, Secretario; don Francisco Arias Jiménez, Tesorero; y los vocales, don Rolando Ugalde Hidalgo y don Federico Pérez Rubín.

En la emisión de esta ley se cometieron errores de discriminación humana y de imprevisión económica para proteger en el futuro a enfermos no asegurados.

En su artículo 2o. se dice que: "La Junta de Protección Social seguirá atendiendo por su cuenta a los enfermos pobres, que no sean miembros del Seguro Social", pero no se garantizan fondos a la Junta para cubrir esa obligación. Ya veremos más adelante como los directores se van para su casa porque nadie les ayuda a pagar las hospitalizaciones.

Si bien se dice en el párrafo segundo que las estancias se pagarán de las rentas de la Junta, éstas: mandas de beneficencia, subvención muy reducida del Estado y Municipal solamente, porque ya las fincas y los peones no aportan sus contribuciones.

La Caja del Seguro Social destacó un administrador don Roberto Mora Gallini, para el control del Hospital. La Directiva de la Junta siguió reuniéndose en el edificio, pero ya no con eficiencia porque ya no era propiedad de la Institución.

(CONTINUARA)

MEDICINA DE LA COLONIA

José María Barrionuevo Montealegre

(CONTINUACION)

PREVENCION E HIGIENE

La ciencia suponía que las casas, los enseres y las ropas de los lazarinos trasmitían la enfermedad. Lo cual motivaba, para evitar el peligro de contagio, que fueran saneadas las primeras, picándole las paredes tanto interior como exteriormente, renovándoles los pisos y lavando las ventanas, puertas y techos con vinagre u otro desinfectante conocido. Esta labor, así como el envío de ropas y muebles al fuego, tenía que hacerse ante la estricta vigilancia de los justicias (alcaldes de barrio y celadores).

Las medidas preventivas y profilácticas expuestas por el señor de Acosta en su plan se mandarían a ejecutar con rigurosidad, ya que él creía en la curabilidad de la lepra.

Nuevamente en 1806 nos volveremos a encontrar con el preocupado y responsable gobernador D. Tomás de Acosta, con motivo de una serie de preguntas que tuvo que evacuar al Protomedicato de Guatemala sobre el tema y que forman parte de la contestación y que señalamos como "Lepra. Certificado Prenupcial".

A.C. 963 y 964. Febrero 23 de 1805. Bando del Gobernador: cierre dominical.

D. JOAQUIN DE OREAMUNO Y MUÑOZ DE LA TRINIDAD

Teniente Gobernador de Costa Rica
1799

Aparece ejerciendo el mando de la provincia, en el año señalado, esta autoridad. Eran tiempos del gobernador propietario D. Tomás de Acosta.

FUENTES DE AGUAS MEDICINALES

Agua Caliente, Cartago
Fines del Siglo XVIII

HISTORIA

La fuente termal de Agua Caliente, situada a tres kilómetros de la ciudad de Cartago había sido conocida antes por un médico, quedando en el olvido hasta fines del siglo apuntado, en que el gobernador D. Juan Flores (1781-1785) se interesó por ella.

Hizo construir esta autoridad española un puente, una casa y un muro de retención del río, así como dos pilas para aprovechar las fuentes consideradas de sumo valor medicinal. Posteriormente, fueron abandonadas dichas instalaciones.

Se encuentran en unos bancos calcáreos, cristalizados por el fuego del volcán Irazú, penetrados por la magnesia y ennegrecidos y calcinados hasta tomar el aspecto de rocas eruptivas. De estos bancos sale la fuente termal, cuya temperatura es de 55° centígrados o 135° Fahrenheit, encerada en un tazón de calicanto. Produciendo los gases que se desprenden, al salir, burbujan que justifican el nombre de "Hervidero" con que también se le ha designado.

CALIDAD DE LAS AGUAS

La buena calidad de esta fuente, superior a otras de gran prestigio, fue considerada por Luciano Platt como fortaleciente, y que podrá utilizarse el hierro que contiene para los convalecientes de temperatura y para las personas de temperatura débil.

En esta corta anotación, de una termal, existen fuentes de investigación histórica muy interesantes, ya que el empleo de Agua Caliente data de la Colonia. Pudiendo existir datos de sumo valor, de aquellos lejanos tiempos, sobre los conceptos de indicaciones terapéuticas y de resultados obtenidos en la práctica.

Un análisis químico de las aguas, hecho a principios del siglo XX, dió los siguientes resultados:

Carbonato de magnesia	0,1 g
Carbonato de hierro	0,2 g
Carbonato de cal	0,4 g
Cloruro de Magnesio	0,2 g
Cloruro de sodio y potasio	0,7 g
Sulfato de magnesia	0,1 g
Sulfato de sal	0,3 g
	2,0 g

Cabe apuntar que posteriormente, a fines del siglo XIX, igual que en el siglo XX se hicieron tentativas de explotación de esta fuente, en debida forma, pasando de nuevo a primer plano. Pero estos últimos datos pertenecen a otros capítulos.

Varias fuentes termales y de aguas medicinales

existen en Costa Rica, algunas de las cuales han sido aprovechadas a la fecha, esperando referirnos a ellas en su oportunidad.

POBLACION DE COSTA RICA
Resumen de Cuadros Anteriores
1700 - 1800

Estimamos interesante, para cerrar el siglo XVIII, hacer un cuadro con los datos recopilados de la población del país, con motivo de los censos efectuados, cada uno de los cuales hemos colocado en la fecha correspondiente.

Esta síntesis nos da los siguientes informes:

	1700	1720	1741	1751	1778
Indios	15.489	13.269	12.716	10.109	8.104
Españoles	2.146	3.059	4.687	7.807	6.046
Ladinos y Mestizos	213	748	3.458	3.057	13.915
Mulatos y zambos (pardos)	1.291	2.193	3.065	2.987	6.053
Negros	154	168	200	62	94
TOTALES	19.293	19.437	24.126	24.022	34.212

Esta etapa de la vida de Costa Rica durante la Colonia, el siglo XVIII, señala el inicio de la extinción de la población original, que vivía a principios del mencionado lapso.

Pudiendo observarse el aumento de la población española en número apreciable (28.2 %). Así como la de los ladinos y mestizos (%); y los pardos y mulatos o zambos (%).

Disminuyendo los negros al mezclarse con otros grupos humanos.

POBLACION DE COSTA RICA
Censo
1801
DIVISION POLITICA

Comprendía esta República, a principios del siglo XIX, la provincia de su nombre y el Partido de Nicoya, siendo su capital durante la Colonia y en los primeros años de la Independencia la ciudad de Cartago.

Su población estaba distribuida, políticamente, de la siguiente manera.

a) *Dos ciudades:* Cartago y Esparza.
b) *Cinco villas:* Nicoya, Ujarrás, Villa Nueva (San José), Villa Vieja (Heredia) y Villa Hermosa (Alajuela).
c) *Cinco anexos:* Guanacaste (Liberia), Bagaces, Las Cañas, Escazú y Pueblo Nuevo (La Unión).
d) *Trece doctrinas:* Barba, Cot, Quircot, Tobosi, Atirro, Tucurrique, Orosi, Curridabat, Aserrí, Pacaca (Ciudad Colón), Boruca, Térraba y Guadalupe.
e) *Tres territorios de indios* no incorporados a la civilización y poco conocidos: Talamanca, Bocas del Toro y Guatuso.

Su distribución política, racial y número de habitantes, de aquel entonces, aparecen anotados en los dos cuadros que aparecen a continuación.

El primero de los mismos lo hemos ajustado a la división política territorial más contemporánea y ordenadas las provincias respecto al número de habitantes de cada una.

Los mismos datos, más detallados, arrojan las siguientes cifras.

DIVISION POLITICA
Separación por Provincias
1801

PROVINCIAS	Ladin. y Mestiz.	Mulat y Zambos	Indios	Españoles	Negros	TOTALES
Cartago	10.614	2.147	1.808	739	30	15.338
San José	9.680	911	1.422	1.854		13.867
Heredia	7.470	840	312	1.908		10.530
Guanacaste	38	4.619	709	63		5.429
Alajuela	2.545	117	800	360		3.822
Limón		150	1.030			1.180
Puntarenas	66	141	900	18		1.125
Territorios de Bocas del Toro, Changomes, Gaymies y Sifus.....			1.300			1.300
TOTALES	30.413	8.925	8.221	4.942	30	52.591

La actual provincia de Cartago, de acuerdo con el cuadro anterior, era la región más poblada y con el mayor número de indios, mulatos y zambos, así como también con los únicos negros.

Luego seguía San José que contaba con más españoles que Cartago. A continuación estaba Heredia con el mayor número de población española. En cuarto lugar Guanacaste con el 75 % de su población formada por mulatos y zambos (pardos). En quinto lugar Alajuela, poblada entonces en un límite reducido de su extensión. Luego Puntarenas cuya población mayor era de indios, sin contar ni con españoles ni con mestizos.

Los territorios de indios, parte de la provincia de Limón de hoy, tenían conjuntamente 1.300 individuos, apareciendo éstos también en otras localidades.

DIVISION POLITICA

Separación por Localidades
1801

LOCALIDADES	TOTALES	Ladin. y Mestiz.	Mulat. y Zambo	Indios	Españoles	Negros
CIUDADES						
Cartago	12.109	9.407	1.745	225	702	30
Anexo: Pueblo Nuevo o La Unión	364	57 66	80 141	212	15 18	
Esparza	225					
VILLAS:		8.547	711		1.837	
Villa Nueva (S. José)	11.095	1.125	200			
Anexo: Escazú	1.325					
Villa Vieja (Heredia)	9.600	7.015	725		1.810	
Nicoya	3.420	8	2.732	662	18	
Anexo: Guanacaste	912	30	790	47	45	
Anexo: Bagaces	672	— —	672	— —	— —	— —
Anexo: Las Cañas	425	— —	425	— —	— —	— —
Villa Hermosa (Alajuela)	3.022	2.545	117	— —	360	— —
Ujarrás	1.500	1.150	322	6	22	— —
DOCTRINAS:						
Barva	930	455	65	312	98	— —
Pacaca (C. Colón)	747	8	— —	722	17	— —
Orosi	650	— —	— —	650	— —	— —
Aserrí	470	— —	— —	470	— —	— —
Térraba y Guadalupe	350	— —	— —	350	— —	— —
Cot	278	— —	— —	278	— —	— —
Boruca	250	— —	— —	250	— —	— —
Curridabat	230	— —	— —	230	— —	— —
Tobosí	132	— —	— —	132	— —	— —
Quircot	105	— —	— —	105	— —	— —
Tucurrique	105	— —	— —	105	— —	— —
Atirro	95	— —	— —	95	— —	— —
TERRITORIOS DE INDIOS:						
Bocas del Toro, Changones, Gaymes y Siguas	1.300	— —	— —	1.300	— —	— —
Talamanca	1.000	— —	— —	1.000	— —	— —
Anexo: Indios del Río Grande	300	— —	— —	300	— —	— —
Anexo: Valle de Matina	150	— —	150	— —	— —	— —
Anexo: Valle de Chirripó	30	— —	— —	30	— —	— —
Guatuso	800	— —	— —	800	— —	— —
SUMAN	52.591	30.413	8.925	8.281	4.942	30

Es interesante anotar aquí que desde principios del siglo XVIII va desapareciendo la costumbre de anotar la raza o grupo social de las personas. Perdiéndose esta costumbre, por completo, poco después de la Independencia del país.

TOSFERINA

Receta de la Real Audiencia 1801

TRATAMIENTO

La Audiencia de Guatemala, en el año señalado, envío la receta para la coqueluche que copiamos a continuación, , a causa de la epidemia que se presentó entonces y que cobró muchas vidas.

Dicen las indicaciones:

"... Si los niños no tienen calentura, si los ataques de tos se terminan con vómitos y en sus intervalos corren bien, juegan y duermen, la enfermedad deberá reputarse como benigna y no acreedora de otros auxilios sino de continuar con la misma dieta, evitando los baños y salidas de casa para que no hagan los muchachos exceso de frío que los agraven, sustituyendo con las frutas agridulces, las más azucaradas, asadas, antes, y cuidando siempre que mantengan el vientre libre, administrándoles de cuando en cuando lavativas, de agua tibia con un poco de azúcar y raspaduras o haciéndoles tomar píldoras de cañafístola.

Pero si es maligna, esto es desde la primera o segunda semana, los niños se ponen tristes, inapetentes, débiles y quieren mantenerse echados (acostados); si tienen calentura o aturdimiento y dolor de cabeza, y si las acciones de tos son muy frecuentes, si la dificultad de respirar es muy continua y se sofocan mucho en los actos de toser, finalizándose siempre con sólo esputos cruentos y éstos se acompañan con grandes flujos de sangre por la nariz y otras vías; entonces la enfermedad es maligna, muy peligrosa y exige ciertamente un método exactísimo y propio de los diversos estados que los distinguen.

El primero es el del contagio, en el que todos o la mayor parte de dichos síntomas o señales van apareciéndose y graduándose y antes de que arriben a su mayor altura deben una o dos sangrías con proporción a la edad, fuerza, dureza del pulso y a la hinchazón o encendimiento que produce la tos en el rostro de los niños; se exceptúan aún a los de segundo año para quienes será suficiente sacarles dos onzas de sangre de uno de los brazos, caso que tengan las señales que quedan dichas, las mismas deberán seguir para los de tres años o cuatro, a quienes se les sacarán tres onzas, cuatro a los que ascienden a siete años y de cinco a seis onzas a los que arriban a doce, en los que se podrá repetir igual operación y aun en los de siete años si presentan aquellos síntomas. Después de la sangría se les hace tomar los tres días primeros por la mañana un vomitivo de polvo de ipecacuana de la tierna que los haga lanzar bien cuanto tengan en el estómago, dándoles a los niños un grano de dicho polvo disuelto en una cucharada de leche y repitiéndoles de cuando en cuando. Se hará igual toma hasta que se realice el vómito; a los de dos años se les dará dos granos de la misma forma aumentándoles siempre con respecto a la edad y aun duplicándoles o triplicándoles si fuera necesario.

Pasados estos días se continuará todas las mañanas dándoles una vez los granos de polvo que basten a causar ligeras bascas, aumentándolos cada cuatro días cuanto baste para hacerlos vomitar.

En todo este tiempo los alimentos serán caldos de gallina o vaca, leche cocida y desnatada y atolitos delgados y bien cocidos de trigo, arroz o maíz; tomarán el cocimiento de cebada de arroz y si les atacaran dolores en el ámbito del pecho se fijarán inmediatamente sobre la misma parte un vejigatorio de cantáridas y en su defecto de cal viva y jabón que deberán quitarse luego que haya levantado el pellejo, curando después la llaga con una hoja de col barnizada de manteca de puerco.

No usarán caramelos, mieles ni jarabes, cuidarán de que el vientre esté corriente con las lavativas y pócimas de caña fístula. Suspendiendo así el estado contagioso que es el más peligroso se intentará lo mismo con el segundo, que comienza cuando la calentura ya es más suave o ninguna y todas las señales de malignidad se han desvanecido quedando solamente la languidez y el hábito de toser; pero con más largos intervalos de descanso, más apetito y menos tristezas para eso se le dará a los chicos en leche o atol delgado, polvo de quina o colpachí a la madrugada, a las diez de la mañana y cinco de la tarde, haciéndoles tomar a los de un año en cada ocasión dos granos de dichos polvos, cuatro a los de dos años, ocho a los de cuatro y doble porción a los de siete años; se redobla a los de doce, midiendo estos granos por lo que pesa un grano de cebada.

En el principio de este segundo período se continuará con los alimentos y agua de pasto pero a proporción que vaya convaleciendo y esforzando a los niños se les irá aumentando poco a poco el alimento hasta que lleguen a tomar el que les es acostumbrado.

Con este sencillo método sostenido con exactitud lograrán los indios y demás pobres de las otras costas libertar a sus hijos de este formidable mal sin necesidad de tomar opio, alcanfor, azafétida, de ningún piridado y otras drogas de mal modo confeccionadas que a más de su valor y difícil de hacerlas a las manos, me recelo y con razón les serán más dañino talvez que la misma enfermedad."

Continuará . . .

UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO SOCIAL HOSPITALARIO

Lic. Ma. de los A. Ramírez Ulloa
Profesora Escuela de Trabajo Social
Universidad de Costa Rica
Junio, 1979

Continuación . . .

4.2 **Modelo metodológico**

4.2.1 **Modelo escogido**: Se escogió el método básico, expuesto por la Trabajadora Social Ma. Angélica Gallardo[5] al cual se le hicieron algunos ajustes.

4.2.2 **Situaciones para atención prioritaria**: De acuerdo con la experiencia acumulada sobre el trabajo de campo, registrada en informes estadísticos y narrativas; en correspondencia y en expedientes sociales, se escogieron las situaciones para atención prioritaria: la problemática de los enfermos diabéticos; seniles; crónicos; inválidos; con tumores y psiquiátricos.

4.2.3 **Perspectivas del modelo**: Factibilidad de realizar: trabajo social individualizado; investigación a partir de la sistematización de las experiencias de la atención individualizada; proyectos para atender grupos de pacientes con problemática común, permitiendo la proyección en la comunidad, mediante el estudio de recursos y soluciones a nivel local.

4.2.4 **Organización del trabajo**:

—En las Salas y Servicios: Medicina, Cirugía, Gineco-obstetricia, Consulta Externa, Emergencias y Banco de Sangre, la realización de las actividades básicas siguientes: estudio exploratorio sobre la situación de los enfermos atendidos, según prioridad por edad, diagnóstico médico y procedencia. Entrevistas con los pacientes, con los familiares y con los miembros del equipo. Contacto con funcionarios de otras instituciones para la obtención de información o para la coordinación de soluciones a problemas urgentes. Selección de pacientes para su atención dentro de los proyectos.

—Proyectos: Se elaboraron seis proyectos que presentamos en la forma siguiente: un esquema general básico y un resumen de las principales características de ellos.

SISTEMATIZACION – ESQUEMA GENERAL BASICO

NIVEL DE ATENCION	ACCIONES	PASOS METODOLOGICOS	PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Antes de la enfermedad.	Promoción Prevención	Ejecución, sujeta a la programación de otras instituciones de salud.	Coordinación con otras instituciones públicas y privadas. Discusiones en grupo. Orientación personal.
Control médico externo. Hospitalización. Convalescencia. Rehabilitación	Diagnóstico y tratamiento tempranos. Prevención secundaria y terciaria. Rehabilitación integral.	**En todos los niveles siguientes:** Investigación Interpretación Diagnóstica. Programación Ejecución Evaluación	**Para atención individual:** Entrevistas en el Hospital, con pacientes, familiares y miembros del equipo. Visitas domiciliarias. Gestiones. Estudio Social **Para atención en grupos:** Levantamiento de datos; diseño de la muestra. Interpretación diagnóstica. Programación. Dirección, coordinación y entrenamiento del personal. Procesamiento de información y evaluación sistemática.

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS SEIS PROYECTOS DE TRABAJO

PROYECTO	CONCEPTUALIZACION	JUSTIFICACION
Atención de pacientes diabéticos.	Pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus, menores de 65 años, residentes en el Area Metropolitana.	Durante el año 1975 fueron atendidos en el Hospital San Juan de Dios, 407 diabéticos, con una estancia promedio de 15 días. Se registraron 37 defunciones y 47 reingresos.
Atención de pacientes seniles.	Pacientes de ambos sexos, mayores de 65 años, residentes en el Area Metropolitana.	Durante el funcionamiento del trabajo social en el Hospital San Juan de Dios, una de las situaciones más complejas confiadas a su cuidado es la de la población anciana en estado de abandono.
Atención de pacientes crónicos.	Pacientes de ambos sexos, menores de 65 años, residentes en el Area Metropolitana, con dolencias que requieren tratamiento continuo y permanente, bajo grave riesgo si se suspende.	Los pacientes crónicos constituyen un grupo que demanda mucha atención. Confrontan múltiples problemas en el seno familiar y en su desenvolvimiento social.
Atención de pacientes inválidos.	Pacientes de ambos sexos, menores de 65 años, residentes en el Area Metropolitana, incapacitados para las actividades cotidianas: vestirse, comer, caminar, control de esfínteres.	Las personas inválidas confrontan situaciones difíciles muy variadas, desde el problema de su asistencia a tratamiento, hasta el abandono familiar.
Atención de pacientes con tumores.	Pacientes potenciales de cáncer; en tratamiento activado o en control espaciado. De ambos sexos, residentes en todo el país.	La lucha contra el cáncer es de gran importancia en nuestro país, dada su creciente incidencia. Durante el año 1975, en el Hospital San Juan de Dios fueron atendidos 925 pacientes con tumores. Además de los sufrimientos físicos, el cáncer ocasiona angustia de los familiares, y situaciones sociales difíciles, que en parte pueden ser prevenidas, atenuadas o eliminadas.
Atención de pacientes psiquiátricos.	Pacientes de ambos sexos, residentes en el Area Metropolitana, que requieren atención psiquiátrica en nuestro Hospital.	Desde el año 1974 el Hospital San Juan de Dios cuenta con servicio de Psiquiatría, con un promedio de 75 pacientes por mes, en su mayoría con cuadros asociados a su padecimiento somático; psicosis post partum e intentos de suicidio.

La Asociación Costarricense de Hospitales lo invita a usted, empleado hospitalario a participar en nuestras acciones. Por eso hágase socio; solicite informes al tel. 21-49-19.

4.2.5 Evaluación

Con los esquemas presentados anteriormente se trabajó durante un año, hasta el momento del traspaso del Hospital San Juan de Dios a la Caja Costarricense de Seguro Social. Anotamos como logros obtenidos, los siguientes:

– Trascender la atención individualizada, sin eliminarla ni restarle importancia.

– Especialización del personal en cada uno de los proyectos. La atención individualizada de pacientes con diagnóstico común, llevó a considerar otros aspectos comunes también y a programar acciones en grupo; a búsqueda de recursos a nivel local, regional y funcional. El personal de trabajo social empezó a pensar y a actuar en términos de situaciones de grupo, y en términos de acciones amplias a nivel comunal.

– Ofrecer a las autoridades de salud, datos sobre problemas sociales de grupos enfermos, para programas globales y más ambiciosos.

Como obstáculo señalamos el hecho de que la participación de otros profesionales no se dio en toda la amplitud requerida, por lo cual los resultados y proyecciones fueron limitados.

5. PERSPECTIVAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Las perspectivas del trabajo social en el Hospital San Juan de Dios, incorporado a la Caja Costarricense de Seguro Social, los analizamos desde dos puntos de vista.

5.1 Aspectos positivos

La integración del Hospital a un sistema de medicina social con amplia cobertura, dentro de las corrientes de la moderna seguridad social, augura el mejoramiento de recursos, de los sistemas de trabajo, especialmente en la formación de equipos interdisciplinarios y la elevación del status del trabajador social.

5.2 Aspectos negativos

La posibilidad de que se dé, a corto plazo, la burocratización del trabajo social, que puede afectar dos importantes situaciones:

–La creatividad necesaria en los profesionales de trabajo social, quienes debemos enfrentar todos los días problemas nuevos, cada "situación concreta reclama indefectiblemente una forma de acción inédita." [6]

–La demora en los trámites complementarios a la acción de campo, por la jerarquización inconveniente de todo tipo de decisiones.

El tiempo dirá cuáles aspectos han predominado. Esperamos que han de ser los positivos, en beneficio de los pacientes y de la profesión del Trabajo Social.

REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y EL FUTURO DE LA SALUD INFANTIL EN COSTA RICA

Edgar Mohs

Hospital Nacional de Niños
"Dr. Carlos Sáenz Herrera"
Caja Costarricense de Seguro Social y Escuela de Medicina
Universidad de Costa Rica
1979

Esta década que está terminando nos ha enseñado que cuando se enlazan el método científico con la voluntad política, es posible transformar el nivel y la estructura de la salud infantil de todo un pueblo.

Diez años de trabajo tesonero bastaron para que en nuestro país, las causas tradicionales de muerte fueran substituidas por otras "nuevas", propias de una sociedad más organizada; aun cuando este fenómeno tiene raíces históricas y nexos intersectoriales, nuestro grupo pediátrico ha jugado un papel fundamental en este cambio, porque ante la mirada atónita de otros grupos, que creyeron inverosímil esta aventura, sostuvo que era posible y se dedicó a hacerla realidad. Ahora, podemos ver con satisfacción el fruto de tanto esfuerzo y sentir el regocijo de haber sido protagonistas.

Sin embargo, tal contemplación está llamada a ser efímera, porque el surgimiento de los nuevos problemas, reclaman que inmediatamente entremos otra vez en una fase de intenso trabajo para adecuar nuestros recursos físicos, humanos y financieros, al enorme desafío que nos ha planteado la patología compleja que hoy predomina en nuestro medio.

Paradójicamente, haber reducido drásticamente varios problemas consuetudinarios, que a todos preocupaban sobremanera, nos ha puesto en un predicamento, toda vez que la nueva patología exige la utilización de tecnología avanzada, lo cual implica desde modificaciones de planta física y adquisición de equipos sofisticados, hasta la formación de nuevos especialistas; además, queremos perfeccionar los sistemas de atención médica, haciéndolos más eficientes, personales y humanos y debemos desarrollar programas de prevención de malformaciones congénitas, enfermedades metabólicas, cáncer, accidentes, sordera, ceguera, neurosis, etc. En cierta forma, los problemas que antes teníamos, eran más fáciles de encarar, porque requerían menos imaginación, menos tecnología y menos gasto.

Como consecuencia del trabajo intenso que llevamos a cabo en los años anteriores, adquirimos muchas destrezas y alcanzamos madurez intelectual para lidiar exitosamente con los problemas propios de nuestro país; pero el cambio que contribuimos a crear, ocurrió tan rápidamente, que esa experiencia ya no nos sirve, sucediéndonos lo que René Dubos refiere en el caso de los padres cuando en la alborada del mundo moderno, la experiencia que acumularon durante la época anterior, resultó poco útil para sus hijos.

Pasado y presente:

Entre 1970 y 1978, la expectativa de vida aumentó de 66.8 a 71.5 años; la mortalidad infantil bajó de 61.5 a 24 por mil nacidos vivos; la mortalidad en niños de 1 a 4 años de edad descendió de 4.4 a 1.2 por mil; la mortalidad neonatal pasó de 28 a 15 por mil nacidos vivos, volviéndose más importante en un 50 por ciento, que la mortalidad post-neonatal. (Cuadro 1). Este último, es un hecho que únicamente se observa en países desarrollados.

Las muertes por diarrea en el país, se redujeron en un 79 por ciento y las causadas por neumonías, en un 65 por ciento; entre 1970 y 1976, la desnutrición como causa directa de muerte, disminuyó en un 75 por ciento y como causa asociada en un 67 por ciento. (Cuadro 2-3).

En cuanto a las enfermedades prevenibles mediante vacunación, desde 1974 no se reportan fallecimientos por poliomielitis ni por difteria; y las muertes por sarampión se lograron reducir en un 95 por ciento, las de tétanos en un 85 por ciento y por tosferina en un 76 por ciento. (Cuadro 2). En el caso de estos padecimientos, debemos subrayar la importancia de no descuidar ni por un segundo, los programas que hicieron posible el impresionante panorama que acabamos de ver, porque la sombra de una epidemia está siempre al acecho, esperando sólo que se abra una grieta, como sucedió con la acumulación de susceptibles al sarampión, en este año de 1979.

Los parásitos intestinales, prácticamente han dejado de ser causa de muerte en el Hospital Nacional de Niños y la morbilidad que ahora producen es de características clínicas más leves que las que se observaban antes probablemente porque ha disminuido la intensidad de la infestación, como consecuencia de una mejor higiene personal y un mayor saneamiento ambiental.

El decremento de formas graves de estos padecimientos, que demandaban muchas camas de hospital, así como el mejoramiento de los centros hospitalarios de las provincias, permitió reducir 150

camas pediátricas en San José, lo cual es un fenómeno único en América Latina.

Seguramente, la mejoría que se observa en la salud infantil, ha sido favorecida ampliamente por la disminución de la natalidad y el incremento en el peso de los recién nacidos, observándose que los niños con menos de 2.500 gm., de peso, pasaron de 9.06 a 7.24 por ciento del total, entre 1970 y 1975; ambos hechos se encuentran muy relacionados y está bien documentada la relación entre expectativa de vida y nutrición de la población y entre peso al nacimiento y mortalidad infantil (Gráfico 1).

Apenas hace 3 años, en la inauguración de los Congresos Pediátricos que en ese entonces se realizaron en San José, anunciamos con orgullo que las cardiopatías congénitas y el síndrome de insuficiencia respiratoria del recién nacido habían llegado en el Hospital Nacional de Niños a ser causas de muerte tan importantes como las gastroenteritis; ahora, podemos decir, que al haber continuado descendiendo la letalidad por gastroenteritis, nuestras primeras cinco causas de muerte son: malformaciones congénitas, cáncer, síndrome de insuficiencia respiratoria del recién nacido, meningitis purulentas e inmaturidad . (Cuadro 4).

Perspectivas futuras:

Nada es tan importante como escrutar la realidad buscando incesantemente los signos que nos permitirán ver con asombro su intenso dinamismo y sorprender los momentos en que deben hacerse cambios de rumbo; tal actitud nos lleva a establecer macrodiagnósticos o diagnósticos de grandes razgos y tendencias; el detalle, puede ser analizado posteriormente. Así, cuando hablamos de una nueva patología, es porque hemos comprobado el surgimiento de otro panorama, de entre el cuerpo mismo del anterior; éste, no ha desaparecido totalmente y durante varios años debe seguir siendo objeto de nuestra mayor atención, pero indudablemente nos hallamos ahora, frente a una situación distinta, como la ilustra muy bien el caso de la evolución de la gastroenteritis y la desnutrición en Costa Rica (gráfico 2-3; Cuadro 5).

En otras palabras, debemos seguir interesados en los problemas tradicionales y al mismo tiempo hacer un gran esfuerzo para reeducarnos en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los nuevos; con la suma de todos ellos, habremos de construir un nuevo modelo de atención pediátrica.

Hace unos años, los pediatras nos propusimos como meta reducir la mortalidad infantil, la desnutrición y las enfermedades infecciosas comunes y parasitarias; ahora, con igual fuerza que entonces, debemos proclamar los nuevos objetivos y aprestarnos a participar en otra jornada, que estoy seguro nos deparará también, profundas satisfacciones.

Algunos de los pasos que debemos dar, aparecen en la lista siguiente:

PROXIMOS PASOS PARA MEJORAR LA SALUD

GRUPO A

1. Consolidar programas tradicionales y darles enfoque más ecológico.
2. Mayor participación de la comunidad organizada.
3. Educación para la salud (transferencia local de microtecnologías).
4. Responsabilidad individual y desmedicalización.
5. Modificar el patrón de reproducción y darle mayor importancia a la familia (higiene de la reproducción).
6. Lactancia materna.
7. Apoyar la construcción de viviendas de bajo costo. (Erradicación del tugurio).

H.N.N. "Dr. Carlos Sáenz Herrera", 1979.

PROXIMOS PASOS PARA MEJORAR LA SALUD

GRUPO B

- Mayor participación de personal no médico.
- Rehidratación oral precoz en todas las comunidades.
- Control higiénico de los alimentos y control de medicamentos.
- Prevención de malformaciones congénitas, tumores y enfermedades cardiovasculares.
- Prevención del retardo mental.
- Prevención de accidentes e intoxicaciones.
- Prevención de neurosis, violencias, alcoholismo y drogadicción.
- Problemas del aprendizaje y estimulación precoz de pre-escolares.
- Atención del adolescente.
- Exámenes de detección en masa. (Hipertensión arterial, cáncer, diabetes, tuberculosis, infección urinaria, sordera, problemas visuales, enfermedades metabólicas, etc.).
- Programa nacional de prevención de caries.
- Campaña contra el humo y el ruido.

H.N.N. "Dr. Carlos Sáenz Herrera". 1979.

PROXIMOS PASOS PARA MEJORAR LA SALUD

GRUPO C

- Aumentar la participación de la enferma en la atención de pacientes ambulatorios y hospitalizados.
- Desarrollar la medicina del trabajo, del deporte,

adolescente y escolar.
- Tener servicios de emergencias, adecuadamente organizados en todos los hospitales y en las clínicas.
- Crear secciones de medicina social y preventiva en todos los hospitales A y B.
- Implementar formas más personales de atención médica.
- Formar equipos multidisciplinarios para la atención aguda de las emergencias complejas y para la atención a largo plazo de los padecimientos crónicos.

  Mejorar las posibilidades de diagnóstico, utilizando procedimientos no invasivos.
- Incrementar la investigación científica, biomédica, epidemiológica y operacional.

H.N.N. "Dr. Carlos Sáenz Herrera". 1979.

Cuadro No. 1

INDICES DE SALUD EN COSTA RICA, 1970-1978

INDICE	*1970*	*1978**	*°/o Reducción*
Expectativa de vida, años	66.8	71.5	
Tasa de Natalidad por 1000	33.2		11.0
Tasa de Mortalidad:			
General por 1000	6.6	4.3	32.0
Infantil por 1000	61.5	25.0	56.0
1-4 años por 1000	4.4	1.2	65.0
Materna por 1000	0.95	0.5	54.0
Sarampión por 100.000	14.0	0.2	98.0
Diarreas por 100.000	70.2	12.0	79.0

* *Cifras estimadas.*

Hospital Nacional de Niños
"Dr. Carlos Sáenz Herrera'
1979

Cuadro No. 2

MUERTES POR ENFERMEDADES INFECCIOSA EN COSTA RICA

Causa	*1970*	*1973*	*1977*	*°/o Reducción*
Poliomielitis	2	1	0	100
Difteria	16	5	0	100
Sarampión	242	61	8	95
Tétanos	217	113	32	85
Tosferina	49	50	12	76
Neumonía*	437	191	150	65
Diarrea*	836	600	260	73

* *Muertes en niños menores de un año; los demás son total de muertes en la población general; cifras estimadas para 1977.*

Hospital Nacional de Niños "Dr Carlos Sáenz Herrera", 1979.

Cuadro No. 3

DEFUNCIONES POR DESNUTRICION COMO CAUSA DIRECTA O ASOCIADA, NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, SEGUN CODIGO DE ENFERMEDAD* Y EDAD COSTA RICA, 1970 y 1976

	1970 DIRECTA	*1976 DIRECTA*	*REDUCCION %*	*1970 ASOCIADA*	*1976 ASOCIADA*	*REDUCCION %*
Código* 267 268 269.9	31	8	74%	431	152	65 %
Edad, Años						
1	24	6		338	113	
1-4	7	2		93	39	
TOTAL	31	8		431	152	

* *Código Internacional de Clasificación de Enfermedades.*

I.N.I.S.A.

Cuadro No. 4

CAUSAS PRINCIPALES DE MUERTE

1971	*1978*
1. Enfermedad diarreica	1. Malformaciones congénitas
2. Bronconeumonía no especificada	2. Tumores malignos
3. Septicemia	3. Membrana hialina
4. Meningitis	4 Meningitis
5. Inmaturidad no calificada	5. Inmaturidad no calificada

Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera", 1979.

Cuadro No. 5

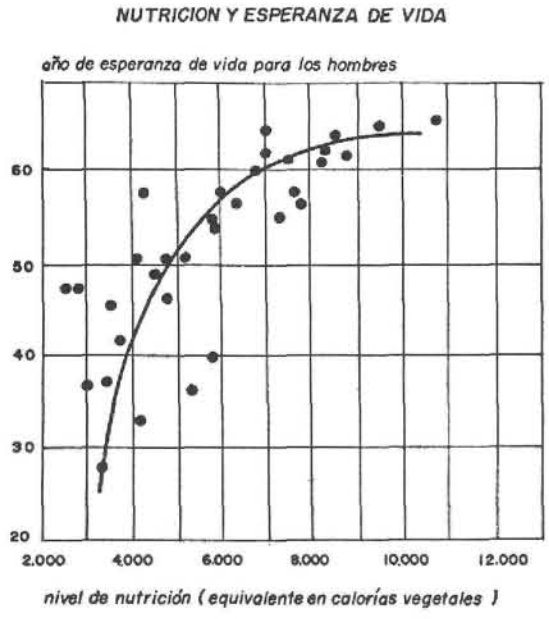
EGRESOS POR DESNUTRICION DE III GRADO SEGUN PESO-EDAD
(Primaria y Secundaria)
(1973 - 1977)

AÑO	*Desnutrición*	*Total egresos*	*o/o*
1973	811	13.146	6.2
1974	696	12.655	5.5
1975	924	12.869	7.2
1976	385	14.253	2.7
1977	322	16.744	1.9
1979	240*	17.000*	1.4

* *Cifra estimada; reducción: 77o/o.*

Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera", 1979.

Gráfico N° 1



Fuente: M. Cépede, F. Houtart y L. Grond, Population and Food, Nueva York, Sheed and Ward, 1964

GRAFICO Nº 2

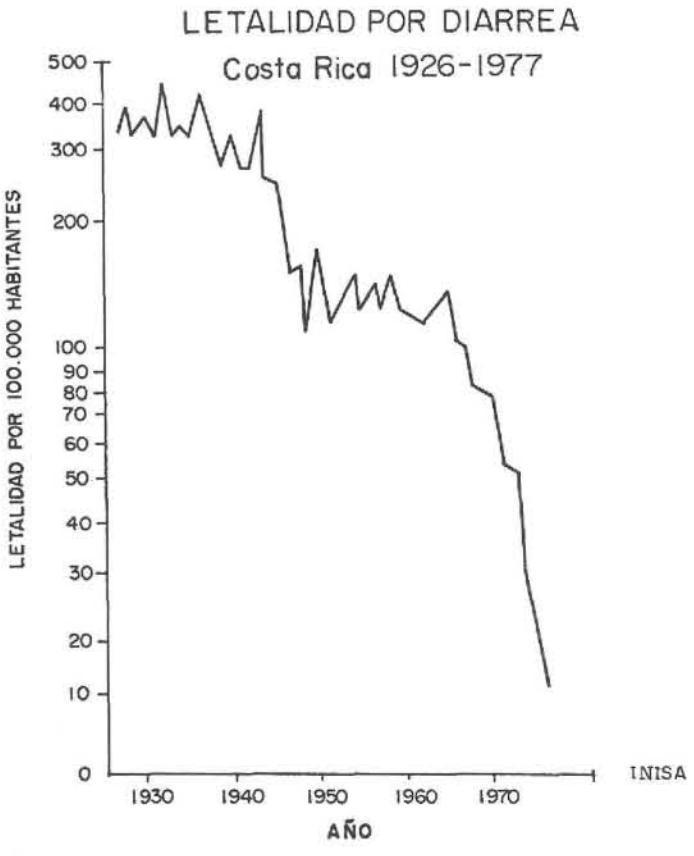
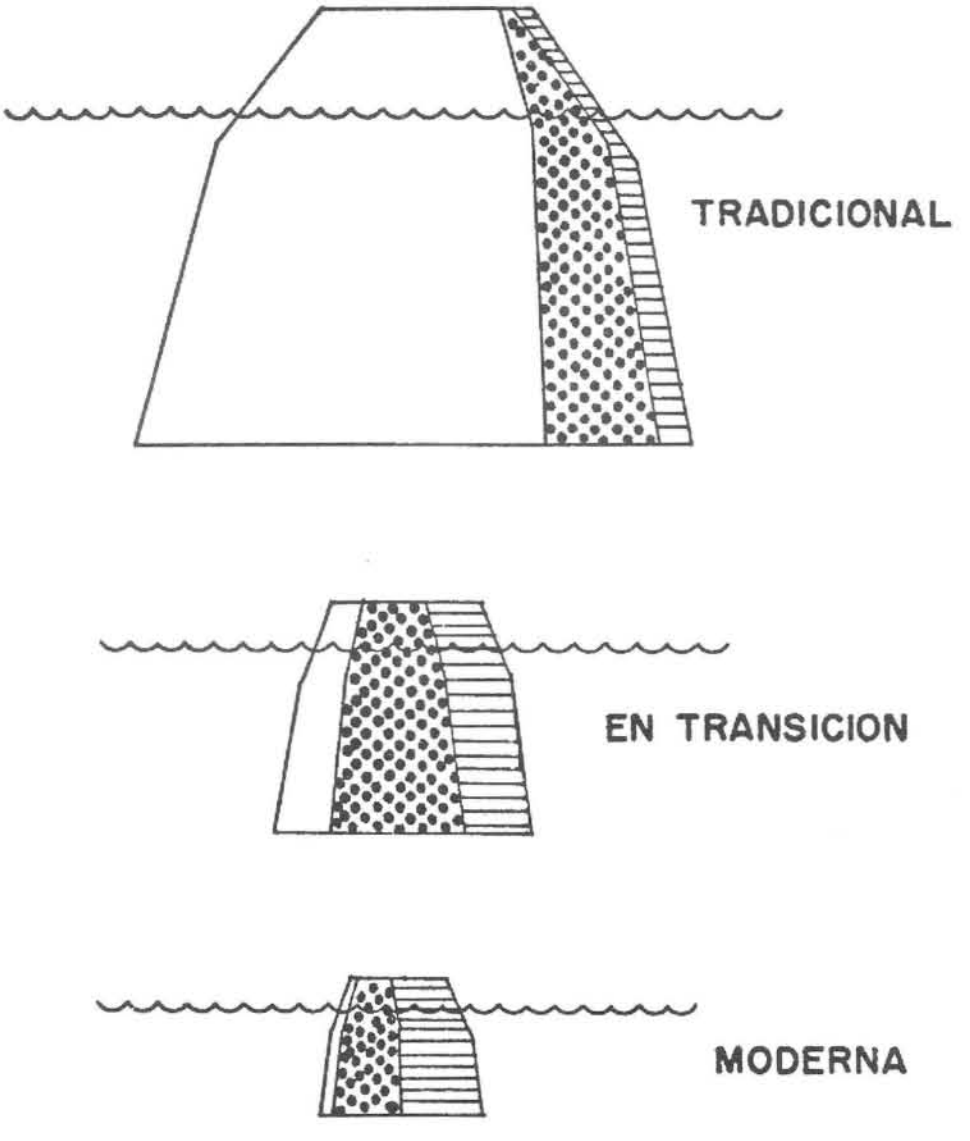


Gráfico N° 3

Desnutrición y Desarrollo Económico - Social



INISA- 1979

INFORMACIONES SOBRE EL IV CURSO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE HOSPITALES

La Asociación Costarricense de Hospitales, se complace en anunciar otro de sus importantes cursos, con el cual se abre el programa docente del año 1980

PROGRAMA DEL

IV CURSO INTENSIVO DE ADMINISTRACION DE HOSPITALES

Del 24 de marzo al 27 de junio de 1980.

TEMARIO

1. El Sector Salud en Costa Rica (16 h.)
   - 1.1 El Ministerio de Salud. Organización y funciones. Plan Nacional de Salud.
   - 1.2 La Caja Costarricense del Seguro Social. Dirección Nacional de Servicios Médicos. Organización y funciones.
2. Principios Básicos de Salud Pública (64 h.)
   - 2.1 Fomento de la Salud.
   - 2.2 Prevención de la Salud.
   - 2.3 Recuperación de la Salud.
   - 2.4 Rehabilitación.
   - 2.5 Epidemiología —Método Epidemiológico. Vigilancia Epidemiológica.
   - 2.6 Bioestadística.
   - 2.7 Principales Indicadores de Salud.
   - 2.8 Saneamiento Ambiental.
3. Principios de Administración (22 h.)
   - 3.1 Evaluación del Pensamiento Administrativo.
   - 3.2 Teorías de Fayol y Taylor
   - 3.3 El PODSCORB de Gullick
   - 3.4 Bases para una adecuada organización. La organización formal.
   - 3.5 El organigrama. Técnica para elaborar organigramas.
   - 3.6 Principales términos y conceptos administrativos
4. Administración por objetivos.
5. Análisis financiero.
6. Organización y métodos.
7. Presupuesto por programas.
8. Contabilidad de Costos.
9. Administración de suministros.
10. Administración de personal.
11. Ciencias de la conducta.
12. Técnicas de la comunicación.
13. Administración hospitalaria (24 h.)
    - 13.1 Definición de términos hospitalarios
    - 13.2 Niveles de atención
    - 13.3 El hospital. Historia. Concepto. Clasificación. Funciones.
    - 13.4 Principales indicadores hospitalarios.
    - 13.5 Organización estructural. Dirección. Organo Asesor. Organo auxiliar. Comités técnicos.
14. Servicios de atención directa (46 h.)
    - 14.1 Departamento de Medicina.
    - 14.2 Departamento de Cirugía.
    - 14.3 Departamento de Gineco-Obstetricia.
    - 14.4 Departamento de Pediatría.
    - 14.5 Departamento de Odontología.
15. Consulta externa.
16. Emergencias.
17. Unidad de cuidado intensivo.
18. Unidad de diálisis renal.
19. Servicios técnicos de apoyo (54 h.)
    - 19.1 Anatomía patológica
    - 19.2 Laboratorio clínico y banco de sangre
    - 19.3 Radiodiagnóstico
    - 19.4 Radioterapia
    - 19.5 Medicina nuclear
    - 19.6 Enfermería
    - 19.7 Trabajo social
    - 19.8 Farmacia
    - 19.9 Alimentación y dietética
    - 19.10 Medicina física y rehabilitación
    - 19.11 Registros médicos
20. Servicios generales (52 h.)
    - 20.1 Contabilidad y caja.
    - 20.2 Oficina de personal
    - 20.3 Mantenimiento
    - 20.4 Lavandería y ropería

20.5 Almacén y suministros
20.6 Intendencia

21. Atención comunitaria

22. Prácticas de campo

22.1 Hospitales
22.2 Atención ambulatoria comunitaria

23. Presentación y discusión de trabajos

INFORMACIONES SOBRE ACTIVIDADES DOCENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

1. IV Curso Nacional de Administración de Hospitales, del 24 de marzo al 27 de junio de 1980, San José, Costa Rica.
2. VIII Conferencia Regional de Hospitales, del 23 al 27 de junio de 1980, Río de Janeiro, Brasil.
3 VI Congreso Internacional de Ingeniería Hospitalaria del 7 al 11 de julio de 1980, Washington D.C.
4. Vigésimo Segundo Congreso Internacional de Hospitales, Sydney, Australia, del 18 al 23 de octubre de 1981.
5. Course for Santor Hospital & Health Service Administrators from Overseas, del 8 de julio al 19 de setiembre de 1980, Londres, Inglaterra.
6. Vigésimo Tercer programa anual para Directores en Salud, Escuela de Negocios y Administración Pública Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York, del 16 al 20 de junio de 1980.
7. Primer Congreso sobre Sistemas Científicos en Salud, Montreal, del 14 al 17 de julio de 1980.
8. Viaje de Estudios de Hospitales de la Federación Internacional de Hospitales en la República Federal de Alemania del 11 al 22 de mayo de 1980.
9. Sexta visita especial de estudio de la Federación Internacional de Hospitales. El Control de Calidad, del 3 al 14 de agosto de 1980. Asociación Americana de Hospitales, Estados Unidos de América.
10. Visitas especiales de estudio de la Federación Internacional de Hospitales, Servicios Sanitarios Cordinados en una región. Suecia, 1 al 10 de junio de 1980.
11. El desarrollo de los servicios sanitarios mentales extensivos. Inglaterra, 7 al 19 de setiembre de 1980.

HUMANISMO Y MEDICINA

Dr. José Amador Guevara.
Ex-Director Salubridad Pública

No es posible imaginarnos un médico sin cultura humanista. La cultura no constituye una carga para nadie, y menos aún para el profesional de la medicina.

Si no la posee, podrá ser un competente técnico —que vende conocimientos— pero no logrará, jamás, comprender todo el maravilloso universo del hombre.

Más que una técnica la medicina debe estimarse como una filosofía de la vida. La técnica no puede ser opuesta al alma, y al dolor del ser humano. El enfermo busca más que a un técnico a otro hombre que sepa hermanarse con él y poder compartir así toda angustia que lo amenaza.

La medicina tiene una relación directa con el hombre. Por tanto, todo lo que a este preocupa debe constituir, también, preocupación de quien se ha lanzado a la maravillosa aventura de ejercer tal disciplina. Sin alegar al extremo de la famosa sentencia de Letamendi —autor de clásicos textos de patología y clínica—, "DE QUE EL MEDICO QUE SOLO MEDICINA SABE NO SABE NI MEDICINA SIQUIERA", es evidente que la cultura humanista lo acerca más al hombre. Lo hace más comprensivo, generoso y bueno, y también más eficiente.

Debe buscarse en la cultura la inspiración necesaria para actuar, no únicamente como profesional capaz, sino para entender en toda su magnitud los serios y complejos problemas que conmueven a la humanidad.

La cultura debe constituir para el médico su esencial preocupación. El sabio hispano Santiago Ramón y Cajal, exclamaba: "Se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de cultura. Urge, en efecto —agregaba— si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yernos de nuestra tierra y de nuestro cerebro, salvado para la prosperidad y enaltecimientos patrios , todos los ríos que se pierden en el mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia".

Recomendar la formación de médicos enciclopédicos convertidos en "Archivos" de conocimientos, a veces superficiales y fríos, no es constructivo. Por el contrario, la formación humanista hará más por el progreso y la civilización en general que aquellos, además, permitirá al profesional a comprender todo el drama humano. Y por lo tanto cumplir con su elevada misión.

El médico, necesita, cada vez más, de humanismo, como el árbol demanda la lluvia y el sol.

Sólo hay un camino para llegar al fondo de la ciencia, el espíritu templado del humanismo, expresa con acierto el maestro, Gregorio Marañón.

Cuando el Dr. Ignacio Chaves, fundador y director del Instituto de Cardiología, de México, estuvo en Costa Rica, donde contaba con un numeroso grupo de alumnos y admiradores, expresó en la Universidad de Costa Rica, los siguientes conceptos:

"El humanismo no es un lujo ni un refinamiento, de estudiosos que tienen tiempo de gastarlo en frivolidades disfrazadas de satisfacciones espirituales. Humanismo quiere decir cultura, comprensión del hombre en sus aspiraciones y miserias; valoración de lo que es bueno, lo que es bello y lo que es justo en la vida; fijación de normas que rigen nuestra vida interior, afán de superación que nos lleva, como en la frase del filósofo: "A igualar la vida con el pensamiento".

Esa es la finalidad del humanismo al hacernos cultos, la ciencia es otra cosa; nos hace fuertes pero no mejores. Por eso el médico entre más sabio debe ser más culto". Y más bueno, agregamos nosotros.

Nuestra preocupación de siempre: formar un médico que sea capaz de asumir con toda plenitud su responsabilidad; un médico que valore debidamente las implicaciones sociales y económicas que acompañan siempre al progreso patológico; un médico que sea algo más que un técnico del protoplasma", un médico que realiza su profesión con sentido humano y social dentro del marco, de la más elevada comprensión humana, un médico, que sea, en fin, un hombre integral en el más amplio sentido del vocablo.

El médico debe tener una sola aspiración: vivir, como profesional y ciudadano, con amplitud, intensidad y con verdadero sentido humanista hasta el último instante de su fugaz existencia.

LA PARTICIPACION DEL HOSPITAL COMO GENERADOR DE DESARROLLO Y BIENESTAR HUMANO EN SU AREA DE ATRACCION*

(Hospital sin paredes)

Por Dr. Juan Guillermo Ortiz Guier, Director Hospital de Alajuela, Costa Rica.

* Conferencia presentada por el autor en el 1er. Congreso Latinoamericano de Hospitales, Caracas, Venezuela, Setiembre 1970.

I. INTRODUCCION:

La República de Costa Rica está situada en América Central, y tiene una extensión de 50.900 Km^2 y una población de 2.070.000 habitantes (al 1 año 1977) de los cuales un 45°/o viven en áreas urbanas y un 55°/o en medios rurales.

Política y administrativamente se divide en 7 provincias, 80 cantones y 409 distritos. Dispone de un médico por cada 1.210 habitantes, 26 hospitales, 129 centros de salud en las cabeceras de cantón y 341 puestos de salud distribuidos en los distritos, además de otros centros de atención especializada y clínicas privadas.

Al año 1977 un 86.16°/o de la población estaba cubierta por el seguro de enfermedad y maternidad.

Costa Rica ha logrado crear una mentalidad de tradición civilista enraizada en su realidad nacional. La prescripción constitucional del ejército como institución desde 1949 contribuye a entender su singularidad histórica. Al no gastar presupuesto en armamento los gastos de salud y educación se incrementan en tal forma que absorben un 42.9°/o del presupuesto directo del Poder Central sumándole el gasto en salud de la seguridad social.

Entre los indicadores más significativos de la importancia dada tanto a educación como a salud están los siguientes: El índice de analfabetismo fue, para 1977, de 9°/o en la población mayor de 10 años. Para ese mismo año la esperanza de vida al nacer fue de 73 años y la tasa de mortalidad infantil fue de 28.1 por mil.

El Programa de Salud Comunitaria de San Ramón:

En los países latinoamericanos el hospital tradicional ha sido una institución de puertas cerradas en la cual se reciben pacientes, sin preocuparse hondamente de lo que sucede en la comunidad —su área de atracción que es donde la enfermedad se gesta y avanza. En estos hospitales se concentran los mejores recursos, derivados de presupuestos pobres— y no se utilizan en forma racional de acuerdo a las verdaderas necesidades del pueblo.

Además, nuestro país cuenta con una clase marginada, que produce la mayoría de la mortalidad infantil en menores de un año, motivos por los cuales el hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega, del cantón de San Ramón, Provincia de Alajuela, se ha propuesto desarrollar un programa con la participación activa de la comunidad y el personal intra y extra hospitalario con excelentes resultados, objetivamente en los índices de salud del área y en el desarrollo general de la misma el Programa de Medicina Comunitaria denominado Hospital Sin Paredes, se extiende en un área de influencia hospitalaria de 1351 Km^2 que cubre una población aproximada de 82.000 habitantes.

Lo cual significa una cobertura de un 2.6°/o del territorio nacional y un 4.0°/o del total de la población. En él se ha utilizado el componente salud como punta de lanza de penetración para lograr desarrollo social.

Cobertura del Programa "Hospital Sin Paredes" – 1978

CANTON	*POBLACION*		*SUPERFICIE*	
	Número	*Porcentaje*	*Km^2*	*Porcentaje*
San Ramón	36.735	45.0	981	72.6
Palmares	15.786	19.3	38	2.8
Alfaro Ruiz	6.915	8.5	156	11.6
Naranjo	21.836	26.7	126	9.3
Toro Amarillo	388	05	50	3.7
TOTAL	81.660	100.0	1.351	100.0

* *Distrito del Cantón de Valverde Vega*
Fuente: Archivos Programa.

Algunos indicadores de salud para Costa Rica y para el área cubierta por el Programa Hospital Sin Paredes. 1977.

Indicadores	*Costa Rica*	*Area cubierta por el programa*
Mortalidad infantil	28.1 por mil	16.0 por mil
Mortalidad 1 a 4 años	1.5 por mil	0.42 por mil
Mortalidad en general	4.3 por mil	3.85 por mil
Partos institucionales	81.9°/o	98.0°/o

Fuente: Anuarios Estadísticos Ministerio de Salud.

La tasa de mortalidad infantil para el total del área cubierta fue de 16.0°/o pero se presentan diferencias importantes entre los cantones que la constituyen: el cantón de Naranjo, que fue el más reciente en incorporarse al Programa (en 1976) con una tasa de mortalidad infantil de 62°/o, ha reducido este índice a 29.0°/o. Los tres cantones restantes tienen una tasa promedio de mortalidad infantil de 12.0°/o.

Una investigación sobre el 100°/o de fallecimientos de menores de un año, en San Ramón y Palmares, mediante este Programa, revela que los grupos que están aportando las muertes infantiles son aquellos formados por familias pertenecientes a clases sociales marginadas y en las cuales la mejoría de sus condiciones de vida pasa a ser prioritaria para lograr nuevos avances en salud.

Consideramos que para que haya habido los avances de salud manifestados en los indicadores anteriores es porque han sido producto del desarrollo integral de la zona en cuya motivación y trabajo ha participado el Programa "Hospital Sin Paredes", hondamente a través de su infraestructura y la participación comunitaria, como lo expondremos más adelante.

II. HISTORIA:

1. Breve reseña histórica del Programa:

Se puede decir que el punto de partida del Programa lo constituyó la creación del primer puesto de atención primaria de salud (Puesto de Salud) en 1971, pero se necesitó un período de gestación de 15 años para crear las condiciones previas para iniciar el Programa.

Desde 1955 se realizó un gran esfuerzo tendiente a mejorar la atención intra-hospitalaria, pero sobre todo se luchó por integrar los servicios del Hospital (dependiente de una Junta de Protección Social local) con los que brindaban los Centros de Salud, dependientes de instituciones diversas (Ministerio de Salud y las comunidades mismas).

En 1962, en un intento por proyectar esta integración al resto de los servicios de salud del país, se presentó un trabajo escrito a una comisión formada por varios Ministros de Estado (ver anexo) pero esta propuesta no fue aceptada en esa época para su implementación a nivel nacional.

Sin embargo desde el año 1962 se produjo un salto cualitativo en el desarrollo del Programa con el establecimiento, a nivel local de diversos proyectos de salud con participación directa de la comunidad:

a. Proyecto sobre alcoholismo.
b. Proyecto prevento-curativo de T.B.C.
c. Proyecto del enfermo crónico, senil e inválido.
d. Proyecto de psiquiatría intra-hospitalaria, que luego se extendió a la comunidad.
e. Visitas de personal voluntario del Hospital a los distritos campesinos.
f. Programa comunitario y de investigación de hepatitis.

En 1970 se escribió un documento en el cual se explicaba el Programa actual y se creaba el primer Puesto de atención de salud primaria en el país con la metodología respectiva de visitas domiciliarias casa por casa, etc., documento que fue llevado al señor Ministro de Salud en esa época, Dr. José Luis Orlich quien le dio su aprobación incluyendo la integración de servicios de salud de la comunidad hasta conseguir que se trabajara como una sola unidad funcional, con lo que se evitaba la duplicidad de servicios y se brindaba atención más eficiente a la comunidad a través de proyectos concretos dirigidos sobre todo a la población campesina del área y especialmente a las clases más marginadas.

En 1971 se dio inicio al Programa con la construcción de varios Puestos de Salud que permitieron la mejor cobertura del área. Estos Puestos de Salud fueron construidos en su mayoría con contribuciones aportadas por las mismas comunidades en un 80°/o y con un 20°/o del gobierno, hasta lograr en 1976 cubrir toda el área con un total de 44 puestos de Salud. Además, el 100°/o del equipo fue comprado por las comunidades. Entretanto el Programa creció en profundidad, en organización y participación popular de manera que logró convertirse en un ejemplo para el resto del país, de tal manera que en 1978 el Gobierno tomó la decisión política de llevar este tipo de organización popular al resto del territorio nacional, para lo cual se ha empezado a tratar de reproducir la organización comunitaria del Programa Hospital Sin Paredes y además se escogió para la preparación de Responsables de Salud para todo el país.

III. FUNCIONAMIENTO BASICO DEL PROGRAMA:

El Hospital, los Puestos de Salud y los Centros de Salud están bajo una sola Dirección Administrativa a nivel regional, tratando de entregar una medicina integral, como una dependencia del Ministerio de Salud de la Junta de Protección Social local, de comunidades organizadas del área. Esta política de acción se lleva con una participación activa de los pueblos organizados.

Los Puestos de Salud están atendidos por Auxiliares de Enfermería, supervisados por Enfermeras Graduadas. A todos ellos llegan médicos generales y especialistas en pediatría y gineco-obstetricia en forma regular. A nivel local todas las

comunidades están organizadas en Asociaciones de Desarrollo y Comités de Salud. También en cada una de ellas hay un Responsable de Salud que participe, entre otras cosas, como enlace entre la comunidad y el equipo de salud y finalmente participa en ese equipo local un maestro por escuela.

Se ha establecido un sistema escalonado de atención desde el domicilio hasta el Hospital de San Ramón, que es el hospital base, pasando por los Puestos de Salud con un sistema de doble vía a través de referencias y de acuerdo con una programación comunitaria que está representada por una Asociación de Salud y 180 Responsables de Salud que se conjugan en esta estructura, contactando y coordinando en primera instancia con el personal destacado a nivel del Puesto de Salud, como lo son las 52 Auxiliares de Enfermería, 7 Enfermeras Graduadas Supervisoras, el equipo local y central multidisciplinario. Se contempla también la educación permanente en servicio a todos los componentes del programa. Se revisan periódicamente los diversos indicadores de salud y se realizan semanalmente reuniones de auditoría en que se analiza lo actuado y se establecen responsabilidades frente a la enfermedad y la muerte.

La creación de Puestos de Salud, fijos en las comunidades, con auxiliares de enfermería supersiadas por enfermeras graduadas y con visita periódica y estable por médicos debidamente entrenados y con acciones de salud programadas previamente, se ha realizado a través de las siguientes etapas:

1.—Motivación de la comunidad: aún antes de ponerse en funcionamiento el primer Puesto de Salud se hizo una labor de convencimiento para que la comunidad participara activamente y que comprendiera los posibles alcances que tendría el programa.

2.—Encuesta socio-económica: la cual se realizó también como paso previo y con el fin de establecer un diagnóstico de salud y con él las acciones prioritarias.

3.—Organización de un Comité de Salud, con participación comunitaria, que coordinada con la Auxiliar de Enfermería, con las Asociaciones de Desarrollo Comunal son un nexo entre la comunidad y el equipo central del Programa.

4. —Instalación del Puesto de Salud contando con una Auxiliar de Enfermería permanente y entregando servicios mínimos de salud, primeros auxilios, saneamiento ambiental, educación para la salud, nutrición y organización comunal.

Cada Puesto recibe la visita del Médico General cada ocho días, la del Pediatra cada 15, del gineco-obstetra cada mes, como promedio, además del Inspector de Saneamiento Ambiental, de Nutricionistas, dentistas, trabajadoras sociales y laboratoristas.

En cada Puesto de Salud se lleva un archivo familiar y con todos los datos de vivienda, medio ambiental de la familia. Además datos personales de cada miembro de la familia, incluyendo vacunación, crecimiento y desarrollo prenatal, enfermedad, etc.

Entre otros aspectos operativos de esta organización se pueden señalar:

1.—Descentralización ejecutiva: de manera de crear un sistema que permita dar la atención médica lo más cercana posible al domicilio de los pacientes para conseguir la máxima penetración y cobertura, centrando el proceso de atención médica en los Puestos de Salud.

2.—Sectorización y trabajo en equipo: diseñando zonas geográficas de trabajo de las cuales se hace responsable a un equipo multi-profesional.

3.—El especialista médico no sólo participa en la consulta externa del Hospital sino trabajando con programas de cobertura total de la población de la zona

4.—Continuidad de los programas integrando lo preventivo y lo curativo.

5.—Evaluación permanente a través de diversos medios.

- A través de la enfermera jefe y de todo el equipo de salud con la participación de los Responsables de Salud.
- Registro al día de todos los fallecimientos para detectar los cambios en el nivel de salud, estructuras de muertes y auditorías de fallecimientos.

6.—Acentuación de la formación y capacitación del personal: una vez por semana se reúne todo el equipo de salud a recibir adiestramiento y coordinar las futuras tareas.

7.—Fomento de la educación integral de la familia.

8.—Participación organizada de las comunidades.

9.—Fomento de las investigaciones.

10.—Acciones coordinadas con la Asociación de Desarrollo local tendientes a incrementar el ingreso socio-económico de las familias, promoviendo la distribución adecuada de la tierra, vivienda, letrinización, vestuario, agua potable, electrificación, teléfonos, vías de comunicación, asentamientos campesinos, mejor nutrición, educación en general, deportes y recreación.

En nuestro actual y nuevo concepto de Hospital Comunitario vemos como un todo los diferentes niveles de atención a la Salud, o sea el hogar, el Puesto de Salud, el Centro de Salud, la consulta externa intrahospitalaria, la atención del paciente encamado en el Hospital. Los diferentes profesionales y técnicos de nuestra organización trabajan prácticamente en todos los citados niveles

de atención de salud, como son: médicos generales, gineco-obstetras, pediatras, enfermeras obstétricas, supervisoras de enfermería, auxiliares de enfermería, odontólogos, laboratorios, asistentes de nutrición, inespector de saneamiento, y la comunidad, para que puedan tener una visión global del ciclo de atención de la salud en la comunidad.

Todo ello en una corriente de doble vía: del nivel hospitalario hacia abajo hasta el hogar y del hogar hacia el hospital.

Los programas básicos que se desarrollan en esta zona son los siguientes:

1. Programa materno-infantil y bienestar familiar
   Sub-programa de planificación y bienestar familiar
2. Programa atención médica y referencia de pacientes
   Sub-programa odontólogico
   Sub-programa de salud mental.
3. Programas de epidemiología
   Sub-programa de enfermedades prevenibles y de vacunación
   Sub-programa control de tuberculosis
   Sub-programa control de enteroparasitosis
   Sub-programa control de zoonosis
   Sub-programa de investigación epidemiológica
4. Programa de saneamiento ambiental
5. Programa de educación para la salud
6. Programa de capacitación de personal

No nos referiremos en este trabajo a cada uno de los programas, pero sí diremos que todos y cada uno de ellos se proyecta la participación comunitaría, que ha sido promovida en parte por el hecho de haber llevado estos Programas al pueblo. En esta forma es como utilizamos los clásicos recursos intra-hospitalarios concentrados tradicionalmente en el citado nivel a todos los aspectos de atención, con un espectro educativo profundo que motiva la promoción y desarrollo integral del cien por ciento de los habitantes del área, economizando recursos financieros y utilizándolos en una forma más efectiva, como lo demuestran los índices de salud logrados en el área y la organización alcanzada en algunas comunidades vecinas.

IV LOGROS:

1. En Salud:

Desde el inicio del programa se ha visto un cambio fundamental en los indicadores de salud, que revelan el impacto que ha tenido sobre el mejoramiento del bienestar de la población, considerando que la tasa de mortalidad infantil que en el área cubierta por el Programa en 1972 era superior a la de Costa Rica, está en la actualidad entre las más bajas del país.

T asas de mortalidad infantil para Costa Rica y para el área cubierta por el programa

Ejemplo:

AÑO	Costa Rica	Area Cubierta
1972	54.4°/o	61.3°/o
1973	43.4°/o	19.4°/o
1978	28.1°/o	16.0°/o

El Programa ha conseguido que la comunidad, al desarrollarse en forma integral produzca salud y bienestar individual y colectivo, basado en sus verdaderas necesidades de salud y no en la clásica demanda de servicios.

Dentro de los programas de salud más relevantes se han realizado proyectos pioneros en la vida nacional:

a) El tratamiento del alcoholismo como un problema social, en el cual las comunidades crearon grupos de lucha contra el alcoholismo en organización hecha por los propios enfermos alcohólicos (Alcohólicos Anónimos, Instituto Nacional sobre Alcoholismo), estos grupos tuvieron amplia acogida dentro del hospital, ya que se les dio cabida como enfermos alcohólicos, cosa que no ocurría en ningún otro hospital del país y que hizo posible que, con posterioridad se generalizase esta forma de tratamiento. También al haberse organizado grupos de jóvenes participando en salud y desarrollo en toda el área ha disminuido en forma importante la tendencia al alcoholismo en las nuevas generaciones.

Se han recuperado más de 1.000 pacientes alcohólicos y existen en el área 50 comités de lucha contra el alcoholismo (ver anexo).

b) A partir de 1966 este hospital general abrió las puertas al enfermo mental ya que anteriormente todos los enfermos mentales del país iban a una sola institución especializada.

En esta forma enfermos mentales que podrían ser atendidos en hospitales generales por médicos generales con la supervisión semanal de un Psiquiatra tuvieron el beneficio de obtener un promedio de hospitalización de doce días en vez de sesenta para enfermos similares. Esta diferencia se debía principalmente al hecho de ser atendidos en el hospital de su comunidad y este tipo de atención se generalizó en el resto del país. Como no teníamos psiquiatras la prevención de salud mental se ha hecho con técnicos y personal paramédico impartiendo cursos de Educación Sexual y bienestar

familiar a nivel de escuelas, maestros y padres de familia en las comunidades dispersas, también se ha hecho divulgación con la colaboración de voluntarios campesinos llamados Responsables de Salud los cuales son elegidos por las comunidades y educados por el Programa.

c) Proyecto del Enfermo Crónico, Senil e Inválido:

En octubre de 1963 el Hospital creó extramuros como un departamento del mismo y desde entonces los ancianos, enfermos crónicos y seniles e inválidos son atendidos en algunas casas individuales incrustados en la comunidad dirigido por una Asociación con personería jurídica que vela por sus necesidades de vestuario y alimentación, el Hospital le envía a ellos médicos y enfermeras.

Este proyecto fue pionero en el país para tratar esta clase de pacientes en una forma descentralizada en los distritos campesinos, promoviendo a las comunidades de que se hagan cargo de sus propios seniles y enfermos crónicos en vez de enviarlos a instituciones centralizadas, para su cuidado y en esta forma al convivir con sus propios vecinos pasan más felices el resto de sus días y las comunidades no rehúyen la responsabilidad de su cuido.

d) Programa de T.B.C.:

En 1967 también nuestro hospital, la Unidad Sanitaria local integraron por primera vez en el país a nivel cantonal un programa prevento-curativo contra la tuberculosis la cual prácticamente ha desaparecido en el área de atracción del Programa.

Otros de los logros importantes en salud ha sido algunas características de la mortalidad en general ya que la mortalidad por enfermedades transmisibles descendió vertiginosamente, la mortalidad perinatal también ha descendido en los últimos años al mismo tiempo que las tres primeras causas de muerte en nuestra zona son:

Causas cardio-vasculares, tumores, accidentes de tránsito.

La mortalidad infantil: la mayor causa es la prematuridad.

La mortalidad en nuestra zona ha cambiado y la gastroenteritis que estaba en primer lugar ha descendido al sétimo y octavo lugar desapareciendo por completo en los últimos cuatro años la mayoría de las enfermedades prevenibles por vacunación como: difteria, tétanos, tosferina, polio. En sarampión ha desaparecido en los niños y ha aparecido uno que otro en adultos.

El porcentaje de defunciones con asistencia médica sobrepasa al 95 por ciento; la vacunación con D.P.T., Polio y Sarampión han alcanzado un nivel de protección de 90 por ciento.

La desnutrición de III grado ha disminuido notablemente que casi ha desparecido del área, la de I y II han disminuido vertiginosamente.

2. *En Organización Popular:*

La población involucrada en el Programa cuenta con representantes que entregan su esfuerzo por el bienestar de la comunidad dentro de una estructura funcional. Los habitantes del área eligen por votación popular 180 Responsables de Salud, 76 Comités de Salud, que suman un total de 556 líderes, 64 Asociaciones de Desarrollo Integral, cuyas directivas las forman 448 líderes. Además eligen 3 Uniones Cantonales con 21 líderes y 7 Comités Juveniles con 49 directivos y finalmente las 125 escuelas eligen entre sus maestros y por votación popular un representante para trabajar en salud y ser el puente de unión de la escuela respectiva para salud y desarrollo; lo mismo hacemos con los 9 colegios de la zona.

Las cooperativas campesinas agrícolas como son la Caficultores, las de leche y las de asentamientos campesinos también colaboran en el Programa. Las sumas de todos estos representantes comunales que es de 1.428 (para una población de 81.600 habitantes) son a la vez los electores de la directiva de la Asociación Regional de Medicina Comunitaria que representa los cuatro cantones.

Algunas características de las organizaciones existentes:

Asociación de Desarrollo: Cuyos integrantes son elegidos por todos los ciudadanos mayores de 15 años de la población y que vela por el desarrollo.

Unión Cantonal: Representa a nivel cantonal a las asociaciones existentes. Coordina comités de deportes, juveniles, de finanzas, de educación, etc.

Comités de Salud: Se hacen cargo del Puesto de Salud con atribuciones para formar sub-comités de agua potable, saneamiento ambiental, biblioteca, teatro popular, etc.

Responsables de Salud: Voluntarios campesinos entrenados para trabajar en salud, detectan problemas, sirven de nexo y colaboran con el equipo de salud en sus relaciones con la comunidad.

Asociación Regional de Medicina Comunitaria: Es el más alto nivel de representación popular en el Programa, ayudan a mantenerlo y mejorarlo asegurando la auténtica representación de la comunidad. Cuenta con sus propios edificios y aulas educativas para uso de toda la población del cantón. Esta Asociación Regional cobija

por definición a todos los habitantes del área; tiene su personería jurídica y coordina con todas las organizaciones populares de la región con el objeto de obtener salud a través del desarrollo, es por eso como en coordinación con la Unión Cantonal se montó una fábrica que produce bloques para la comunidad y en coordinación con la directiva de cooperativa de lecheros trabaja por incrementar dicha Cooperativa. Además de coordinar con las organizaciones de base en la que se entiende con las instituciones gubernamentales privadas y el porder central para hacer pedimentos o reclamos, sirviendo de ejemplo a nivel nacional.

La comunidad por primera vez en su historia, ha tenido acceso a una medicina que aunque imperfecta ha producido avances significativos para ellos que no se reducen sólo a mejoramiento de índices de salud, sino primordialmente a una mayor ciencia crítica del origen de sus problemáticas y una decisión creciente de superarlas a corto plazo.

Para los **distritos** campesinos cubiertos por el Programa, la medicina comunitaria ha significado observar y palpar la posibilidad de trabajar en forma íntegra con las instituciones gubernamentales, así como con otros grupos organizados de la comunidad tratando de formar un equipo multidisciplinario.

Las posibilidades reales de participación, la visualización de los logros obtenidos y la consciencia creciente de su responsabilidad en el desarrollo colectivo han llevado a estos habitantes a realizar todo tipo de acciones en que el esfuerzo mancomunado ha construido en gran parte los edificios de los Puestos de Salud, viviendas para familias necesitadas, han presionado para conseguir la instalación de las obras de infraestructura necesarias y ha colaborado fundamentalmente en la construcción de aulas que sirven para realizar seminarios y Cursos de capacitación a la misma población y de líderes provenientes del resto del país, carretera, agua potable, etc.

Nada ganamos con promover la organización si no la promovemos en la niñez y uno de los logros más importantes en este Programa ha sido el de que por votación democrática y popular los alumnos de 125 escuelas y los 9 colegios del área eligen comités de salud que velan por la salud de sus compañeros, tanto preventiva como curativa y de rehabilitación, una vez por semana dan a sus compañeros un mensaje en educación para la salud, saludo del contacto que tienen con funcionarios del programa y con voluntarios campesinos.

Además se han organizado grupos de jóvenes de muchos de los poblados a nivel del Puesto de Salud que reciben asesoramiento de las Auxiliares de Enfermería de los puestos, de los médicos y de las organizaciones populares así como de las instituciones gubernamentales que coordinan con el Programa.

En este momento existen también entre los logros 10 grupos de teatro campesinos que reciben asesoramiento del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

Otro logro muy importante de la organización popular ha sido el trabajar en equipo muchas veces con los funcionarios de salud y desarrollo, y de coordinar con todas las Instituciones del estado a nivel local como son: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Educación, Agricultura, Universidad, DINADECO, etc.

DINADECO representa en nuestro país la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad que tiene promotores en todo el país, pero en esta área los funcionarios de salud y los de DINADECO trabajan totalmente integrados.

3. En educación:

Creo que si en este Programa hubiera una palabra que tuviera que expresarla mayormente, esa palabra sería Educación. Básicamente nuestro Programa es de educación de adultos y que incrementa la educación y participación de las futuras generaciones.

Así como tradicionalmente se da prioridad a la medicina curativa sobre la preventiva, no se le da la importancia requerida a la educación para la salud. Dentro del contexto del Programa, se ha trabajado hacia respaldar la educación como un factor imprescindible para lograr el desarrollo integral del individuo.

Las actividades educativas dentro del Programa han sido:

a) **Semanas Educativas:**

Se organizan en los lugares rurales dispersos con una metodología innovadora que incentiva la participación artística de la comunidad.

Durante la semana se trabaja todos los días en tres niveles, en la mañana con los escolares, al mediodía con los maestros y líderes de la localidad y en las tardes con toda la comunidad joven y adulta. Durante su desarrollo se presentan Cursos de Desarrollo Comunal, de Nutrición y Educación Sexual y Bienestar Familiar en los niveles mencionados. Además se imparten diferentes charlas. Todas estas actividades son complementadas con proyección de películas, diapositivas y entrega de material educativo.

Continuará . . .

COMISION PARA PREPARAR EL RETIRO Y JUBILACION EN EL SEGURO SOCIAL



La comisión está integrada así: En el orden acostumbrado, don José Antonio Suárez, Secretario; Lic. María de los Angeles Ramírez de Ulloa, Coordinadora; doctor Héctor Guerrero Rojas, Vicepresidente y doctor Carlos A. Granera Padilla, Presidente. No aparece en el cuadro gráfico el miembro vocal, don Juan Guillermo Ramírez Obando.

Comenzó a trabajar con mucho empeño, la comisión que tiene a su cargo la tarea de preparar para el retiro y futura jubilación, a los empleados y funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social que hayan ganado el derecho a estos beneficios.

La comisión la integran: presidente, doctor Carlos A. Granera Padilla, jefe de la farmacia de la clínica Dr. Marcial Fallas Díaz; vicepresidente, doctor Héctor Guerrero Rojas, médico general de la misma unidad; secretario don José Antonio Suárez, de la sección de mantenimiento de la clínica Dr. Solón Núñez Frutos y vocal don Juan Guillermo Ramírez Obando, inspector de la dirección administrativa de la región programática Central Este. Actúa de coordinadora la Lic. María de los Angeles Ramírez de Ulloa, secretaria ejecutiva del centro de capacitación e información sobre la tercera edad.

— 0 —

La Comisión fue creada como resultado del trabajo inicial de la comisión interinstitucional compuesta por personeros del Instituto Nacional de Seguros, Instituto Costarricense de Electricidad y de la Caja, que se ensanchó posteriormente con el establecimiento de grupos filiales a nivel de cada institución. A estos subcomités les corresponde, en primer término, estudiar y resolver los casos que vayan presentando los servidores para quienes ha llegado el momento de pensionarse.

— 0 —

Como parte del programa en marcha la comisión central y las filiales, tendrán el cometido de orientar a los pretendientes a pensión para facilitarles el trámite de su gestión, y también de manera principal realizar una evaluación con respecto a las factibilidades de trabajo, a fin de determinar la capacidad que tienen para dedicarse a quehaceres profesionales de su dominio u otros propios a su idiosincrasia que les permitan desenvolverse en la vida y revelar habilidades aún no puestas a producir, trabajar de nuevo y continuar así siendo personas útiles a la familia y a la sociedad. De modo que la persona que se pensiona no malogre, en aras del ocio y de la desidia, el caudal de experiencia acumulada a lo largo de los años, tan necesario para la supervivencia de él, de los suyos y el medio social. El comité central y los subcomités institucionales, la asesorarán para que asuma determinada

labor y también le señalarán caminos a seguir en el mercado de trabajo nacional.

— 0 —

Para este efecto y con el propósito de darle plenitud al programa, será acondicionada una oficina que servirá de punto de referencia general, en donde se analizarán las posibilidades de ocupación que existan, con acomodo completo al gusto de los interesados, para que se sientan contentos con lo que están haciendo o lo que van a hacer.

— 0 —

El día en que el comité central tenga funcionando su oficina y recurren a ella personas a consultar su situación, se podrá saber entonces si pueden solucionarse de inmediato los casos o deben ser trasladados a la comisión principal, para lo de su competencia.

Aún más, un aspirante a pensión que no sea empleado del seguro, si lo solicita, también recibirá asistencia y orientación del comité y sus filiales, porque estas entidades no van a trabajar a nivel casuístico sino en grado general, o mejor dicho, con proyección a todo el país.

Lo ideal será cuando el comité tenga resueltos, si no todos, al menos la mayoría de los casos que le han sido planteados.

Los precedentes y doctrinas administrativas que se vayan agrupando, servirán de pauta aplicable a los casos similares futuros. Para lograr esto, es cuestión de tiempo, de larga labor y de una organización adecuada de los trabajadores dentro de la filosofía en que se enmarca la promoción humana.

— 0 —

El comité respetará la actitud personal de quien o quienes lleguen a solicitarle ayuda para el trámite de su pensión, puesto que este movimiento no es para obligar a nadie a que se vaya de la institución. Cada uno decidirá su postura y deseo, de acuerdo con sus propias ideas.

El Comité no pretende cambiar el modo de ser, pensar o actuar de ningún funcionario o empleado. El que quiere continuar trabajando, que lo haga en buena hora, según sus aficiones y destreza. El que no, allá con su decisión. No hará la menor presión contra criterios o sentimientos ajenos, sino por el contrario, mantendrá respeto absoluto a la personalidad de los demás.